

Buku Ajar

PENGUATAN PERAN KELUARGA SEBAGAI PENGAWAS MINUM OBAT PADA ANAK DENGAN TUBERKULOSIS PARU

PENDEKATAN FAMILY CENTERED EMPOWERMENT MODEL

Ns. Loriza Sativa Yan, M.N.S

Ns. Syarbaini, M.K.M

Ns. Verra Widhi Astuti, M.Kep

Ns. Rian Yulyana, M.N.S



**BUKU AJAR:
PENGUATAN PERAN KELUARGA
SEBAGAI PENGAWAS MINUM
OBAT PADA ANAK DENGAN
TUBERKULOSIS PARU:
PENDEKATAN *FAMILY
CENTERED EMPOWERMENT
MODEL***

Penulis

Ns. Loriza Sativa Yan, M.N.S

Ns. Syarbaini, M.K.M

Ns. Verra Widhi Astuti, M.Kep

Ns. Rian Yulyana, M.N.S



Buku Ajar: Penguatan Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat Pada Anak dengan Tuberkulosis Paru: pendekatan *Family Centered Empowerment Model*

Penulis: Ns. Loriza Sativa Yan, M.N.S

Ns. Syarbaini, M.K.M

Ns. Verra Widhi Astuti, M.Kep

Ns. Rian Yulyana, M.N.S

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7426-27-7

Terbit: Oktober 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari Penerbit.**

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Instagram: @bimbel.optimal

Tiktok: @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku referensi pembelajaran mengenai "Penguatan Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat Pada Anak dengan Tuberkulosis Paru: pendekatan *Family Centered Empowerment Model*"

Penyusunan buku ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep penting mengenai peran keluarga dalam pencegahan, pengobatan, dan pengawasan kasus tuberkulosis (TB) pada anak. Pendekatan berbasis keluarga sebagai strategi efektif yang dapat menekankan pentingnya keterlibatan aktif anggota keluarga dalam proses perawatan anak yang terinfeksi atau berisiko TB. Serta, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam pendekatan tersebut selama pencegahan dan penanganan TB pada anak yang tepat.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi semua pihak.

Jambi, Juli 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Referensi	4

BAB 2 <i>FAMILY - CENTERED EMPOWERMENT MODEL</i> (FCEM)	7
A. Pengertian	7
B. Tujuan pemberdayaan keluarga	9
C. Tahap-tahap pemberdayaan keluarga	9
D. Ruang lingkup dan tujuan FCEM	11
E. Prinsip-prinsip FCEM	11
F. Contoh Penerapan FCEM dalam Praktik	14
G. REFERENSI	17

BAB 3 PENGAWAS MINUM OBAT (PMO)	20
A. Pendahuluan.....	20
B. Pengertian dan Peran PMO	21
C. Tujuan dan Manfaat PMO	22
D. Kriteria dan Karakteristik PMO yang Efektif.....	22
E. Tugas dan Tanggung Jawab PMO secara Rinci.....	23
F. Strategi Implementasi PMO dalam Program DOTS	24
G. Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas PMO	24
H. Strategi agar tugas PMO berhasil	25
I. REFERENSI	26

BAB 4 TUBERKULOSIS PARU (TB PARU)	31
A. Pengertian	31
B. Penyebab	31
C. Tanda dan Gejala	32
D. Klasifikasi	32
E. Patofisiologi	34
F. Komplikasi	35
G. Pemeriksaan Penunjang	36
H. Penatalaksanaan	36
I. REFERENSI	39

BAB 5 PERAN KELUARGA DALAM PENGAWASAN MINUM OBAT PADA ANAK DENGAN TUBERKULOSIS PARU	41
A. Pentingnya Peran Keluarga dalam Pengobatan Anak dengan Tuberkulosis	41
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Keluarga dalam Pengawasan Minum Obat	46
C. Tantangan dalam Melibatkan Keluarga dalam Pengawasan Minum Obat	47
D. Strategi Penguatan Peran Keluarga	50
E. REFERENSI	53

BAB 6 IMPLEMENTASI FAMILY CENTERED EMPOWERMENT MODEL (FCEM) DALAM PENGAWASAN MINUM OBAT	57
A. Pemberdayaan peran keluarga dalam Pengawasan Minum Obat	57
B. Langkah-langkah pemberdayaan peran keluarga dalam Pengawasan Minum Obat	58
C. Tahapan implementasi Model FCEM	60

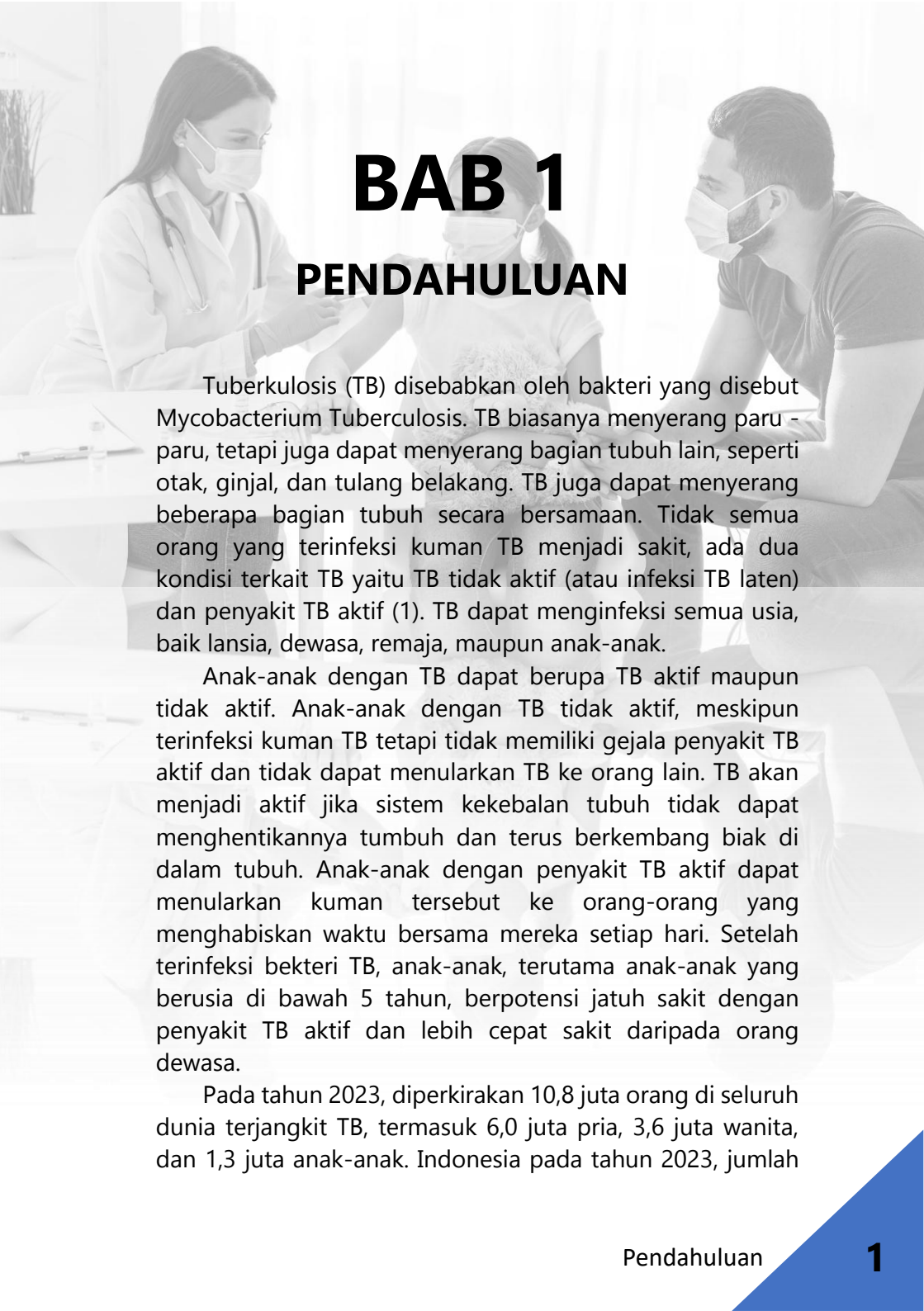
D. REFERENSI	61
--------------------	----

BAB 7 PENDEKATAN BERBASIS KELUARGA DALAM MANAJEMEN TUBERKULOSIS PADA ANAK 64

A. Pendahuluan.....	64
B. Konsep Dasar Keluarga.....	65
C. Fungsi-Fungsi di Keluarga.....	67
D. Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan.....	69
E. Pentingnya pemberdayaan keluarga dalam pengelolaan tuberkulosis anak.....	70
F. Penerapan Tugas Perawatan Kesehatan Keluarga Pada Masalah Tuberkulosis.....	70
G. REFERENSI	75

BAB 8 SOAL LATIHAN..... 78

PROFIL PENULIS 83



BAB 1

PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TB) disebabkan oleh bakteri yang disebut *Mycobacterium Tuberculosis*. TB biasanya menyerang paru - paru, tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lain, seperti otak, ginjal, dan tulang belakang. TB juga dapat menyerang beberapa bagian tubuh secara bersamaan. Tidak semua orang yang terinfeksi kuman TB menjadi sakit, ada dua kondisi terkait TB yaitu TB tidak aktif (atau infeksi TB laten) dan penyakit TB aktif (1). TB dapat menginfeksi semua usia, baik lansia, dewasa, remaja, maupun anak-anak.

Anak-anak dengan TB dapat berupa TB aktif maupun tidak aktif. Anak-anak dengan TB tidak aktif, meskipun terinfeksi kuman TB tetapi tidak memiliki gejala penyakit TB aktif dan tidak dapat menularkan TB ke orang lain. TB akan menjadi aktif jika sistem kekebalan tubuh tidak dapat menghentikannya tumbuh dan terus berkembang biak di dalam tubuh. Anak-anak dengan penyakit TB aktif dapat menularkan kuman tersebut ke orang-orang yang menghabiskan waktu bersama mereka setiap hari. Setelah terinfeksi bakteri TB, anak-anak, terutama anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, berpotensi jatuh sakit dengan penyakit TB aktif dan lebih cepat sakit daripada orang dewasa.

Pada tahun 2023, diperkirakan 10,8 juta orang di seluruh dunia terjangkit TB, termasuk 6,0 juta pria, 3,6 juta wanita, dan 1,3 juta anak-anak. Indonesia pada tahun 2023, jumlah

tertinggi kasus TB yang pernah dilaporkan. Indonesia berada di posisi kedua setelah India dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang negara-negara dengan beban tinggi TB. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan, penemuan kasus tuberkulosis (TB) meningkat pada 2023 hingga 77 persen. Peningkatan itu sebesar 820.789 kasus, dengan penemuan TB pada anak sebanyak 134.528 kasus

TB pada anak mempunyai beberapa dampak negatif baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Bayi dan anak kecil lebih berpotensi daripada anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa untuk berkembang menjadi penyakit TB yang lebih parah seperti penyakit TB otak (meningitis TB) atau penyakit TB milier (penyakit TB di beberapa bagian tubuh). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan serius pada organ bahkan kematian.. Dampak negative pada segi psikologis dan sosial timbul akibat stigma pada TB yang tidak teratasi. Hal ini dapat akan menurunkan kemampuan anak dalam memenuhi tumbuh kembangnya, terutama aspek sosial karena anak tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungan yang menolak dirinya. Anak penderita TB sering kali menghadapi rasa gelisah dan pengertian dalam lingkungan sosial. Stigma TB yang dapat berdampak pada anak antara lain rendahnya harga diri, diskriminasi, pengucilan sosial, dan isolasi yang dapat menurunkan status sosial, menurunkan kualitas hidup, dan kesulitan dalam kepatuhan pengobatan. Sedangkan dampak ekonomi mencakup biaya langsung seperti pengobatan, transportasi, dan layanan kesehatan, serta biaya tidak langsung seperti hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak masuk kerja akibat mengurus anak yang sakit TB.

Pengobatan secara tuntas merupakan satu-satunya cara agar sembuh dari TB. Akan tetapi, pengobatan TB pada anak-anak ini merupakan sebuah tantangan besar karena pengobatannya yang lama 6-9 bulan bahkan lebih dan obat mempunyai efek samping yang beragam sesuai kondisi anak. Anak-anak dengan kondisi fisik dan psikologis yang masih berkembang masih membutuhkan bantuan dari keluarga untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal pengobatan TB. Untuk itu Pengawas Minum Obat (PMO) bagi anak dengan TB mempunyai peran yang sangat penting.

Pengawas Minum Obat (PMO) dapat dilaksanakan oleh tetangga, anggota komunitas, atau keluarga anak dengan TB. PMO mempunyai peran yang sangat penting terhadap kepatuhan anak dalam pengobatan, antara lain: memberikan perhatian dan tidak mendiskriminasi anak yang sakit TB, memberikan motivasi untuk menyelesaikan pengobatan, mengusahakan OAT selalu tersedia di rumah, dan mengawasi anak agar minum obat secara teratur, sesuai dosis, dan meminum obat sesuai jadwal. Anak dengan TB harus menyelesaikan pengobatan selama 6-9 bulan hingga dinyatakan sembuh. Hal ini menimbulkan rasa bosan pada anak-anak. Selain itu, efek samping pengobatan TB seperti pusing, mual, dan muntah membuat anak merasa tidak nyaman dan enggan untuk minum obat. Untuk itu, dalam pengobatan TB anak ini, anak-anak perlu mendapatkan pengawasan dan pendampingan oleh orang terdekat seperti keluarga untuk memantau dan memotivasi anak untuk menyelesaikan pengobatannya.

Memberdayakan anggota keluarga menjadi sumber kekuatan terbesar dalam mendampingi minum obat TB pada anak. Family-centered empowerment model (FCEM) menjadi model pemberdayaan keluarga karena dapat memperbaiki

status kesehatan keluarga dan memperkuat sistem kesehatan didalam keluarga untuk membudayakan perilaku hidup sehat. Untuk itu, pertanyaan penelitian ini adalah apakah Family-centered empowerment model (FCEM) dapat meningkatkan peran keluarga sebagai pengawas minum obat pada anak dengan Tuberkulosis Paru.

A. Referensi

CDC. Tuberculosis in Children [Internet]. (2025). Available from:

https://www.cdc.gov/tb/about/children.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/tb/topic/populations/tbinchildren/default.htm

WHO. Tuberculosis [Internet]. (2024). Available from:

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis#:~:text=1. A total of 1.25 million>

Kemendes. (2024). Kasus TBC Tinggi Karena Perbaikan Sistem Deteksi dan Pelaporan [Internet]. 29 Januari 2024. p.

1–27. Available from: <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kasus-tbc-tinggi-karena-perbaikan-sistem-deteksi-dan-pelaporan%0Ahttps://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240129/2644877/kasus-tbc-tinggi-karena-perbaikan-sistem-deteksi-dan-pelaporan/#:~:text=Komitme>

Manurung N, Harahap RH, Siregar FA, Andayani LS.(2022). Family Support in Increasing Adherence To Treatment of Tuberculosis Patients. Seybold Rep;1276–84.

- KNCV YI. (2024). Mengenal TBC RO pada Anak dan Permasalahannya [Internet]. Available from: <https://yki4tbc.org/mengenal-tbc-ro-pada-anak-dan-permasalahannya/>
- Allender JA, Rector C, Warner KD. (2010). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. p. 413–4.
- Shoghi M, Shahbazi B, Seyedfatemi N. (2019). The Effect of the Family-Centered Empowerment Model (FCEM) on the Care Burden of the Parents of Children Diagnosed with Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2(6):1757–64.
- Kristinawati B, Muryadewi A, Irianti AD. (2019). The Role of Family as A Caregiver in Caring for Family Members that are Suffering from Pulmonary Tuberculosis. J Ners.14(3 Special Issue):362–6.
- Friedman MM, Bowden VR, Jones EG. (2010). Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, & Praktik. V. Tiar E, editor. Jakarta: EGC
- WHO. (2024). Nutritional care for children and adolescents with TB [Internet]. Available from: <https://tbksp.who.int/en/node/2104>
- Gao L, Luo B. (2024). Assessment of Factors Associated With Anti-Tubercular Treatment Compliance in Children: A Cross-Sectional Study. Glob Pediatr Heal. 11:2333794X231199360.
- Goffman E. (2021). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. USA: Prentice- Hall Inc.;

- Astuti VW, Nursasi AY, Sukihananto S. 2019). Structured Health Education And Community Stigma In Lung TB Clients. JPP (Journal Heal Poltekkes Palembang). 14(2):85–90.
- Melati A, Rohmatin T, Putri Karina G, Asri T, Apriani D, Rakhmawati W. (2023). Parent's Stigma Towards Childhood Tuberculosis: A Multicenter Survey from Eastern Bandung Regency. J Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nurs Journal). 9(3):13-23.
- Wati, Ana. (2024). Pendampingan Kepada Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Haliwen. JIKIN 8(1):13–22.
- WHO. (2023). Social support in TB management [Internet]. Available from: <https://tbksp.who.int/en/node/2315#:~:text=^2>
Suitable treatment administration options,for decision-making and reminders.



BAB 2

FAMILY - CENTERED EMPOWERMENT MODEL (FCEM)

A. Pengertian

Kata *empowerment* dalam konteks kesehatan didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengembangkan kontrol lebih besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesehatan. Dalam konteks keluarga, empowerment berarti memberdayakan keluarga agar dapat mengelola dan menjaga kesehatan anggota keluarga dengan cara yang lebih mandiri dan efektif.

Pada dasarnya, proses pemberdayaan keluarga menekankan adanya pengembangan kapasitas keluarga untuk mengenali masalah kesehatan, mengakses informasi yang relevan, serta membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang kuat mengenai pengobatan dan perawatan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada individu pasien, melainkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga dalam berpartisipasi untuk upaya penyembuhan, karena keluarga memiliki peran penting dalam mendukung terapi yang dijalani oleh anggota keluarga yang sakit, terutama anak-anak.

Model pemberdayaan berfokus pada keluarga (*Family Centered Empowerment Model*) adalah upaya kemandirian keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan [15]. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan. Konsep FCEM ini mengidentifikasi efektivitas kemampuan individu dan peran anggota keluarga dalam tiga dimensi yaitu motivasi, psikologis (harga diri dan pengendalian diri), dan karakteristik individu bermasalah (pengetahuan, sikap, dan ancaman yang dirasakan).

Relevansi *empowerment* dalam konteks keluarga sangat tinggi, terutama dalam hal pengelolaan penyakit jangka panjang, pengawasan minum obat, dan perawatan yang memerlukan keterlibatan aktif keluarga. Keluarga yang diberdayakan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan, kesiapan diri dalam menghadapi tantangan terkait pengobatan, dan proaktif terlibat pada proses pengambilan keputusan bersama tenaga medis seperti perawat maupun dokter. Hal demikian juga sejalan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM), yang menekankan pada hak setiap individu untuk memiliki pengetahuan dan kekuatan menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam hal kesehatan.

B. Tujuan pemberdayaan keluarga

Pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada pemberdayaan keluarga berdasarkan teori FCEM, bertujuan untuk:

1. Membantu keluarga untuk menerima, melewati dan mempermudah proses perubahan dalam keluarga
2. Membangun adaptasi yang tinggi terhadap perubahan dalam mengatasi hambatan yang berarti.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh anggota keluarga sesuai tahap perkembangan keluarga
4. Menggali kapasitas atau potensi tersembunyi anggota keluarga
5. Membina dan mendampingi proses perubahan dan menciptakan kemandirian keluarga

C. Tahap-tahap pemberdayaan keluarga

Model pemberdayaan berpusat pada keluarga (*Family Centered Empowerment Model*) oleh Polly A. Hulme (1999) memiliki 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap dominasi profesional (*Professional dominated phase*). Pada tahap ini perawat sangat penting melakukan kontrak awal dan membina hubungan saling percaya pada keluarga serta menjelaskan tentang masalah yang sedang dihadapi dan mengidentifikasi ancaman kesehatan yang dirasakan keluarga
2. Tahap partisipasi keluarga (*Participatory phase*). Tahap ini menggambarkan partisipasi keluarga dalam memberikan perawatan anggota keluarga penyakit kronis dan muncul keinginan meningkatkan kemampuan melakukan tindakan perawatan hingga pengambilan keputusan perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit kronis.
3. Tahap menantang (*Challenging phase*). Keluarga ditantang untuk melakukan modifikasi keseimbangan

pengetahuan dan keterampilan modifikasi lingkungan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa edukasi kesehatan bersama keluarga dan klien. Pada tahapan ini sangat penting memberikan apresiasi diri positif atau pujian terhadap kemampuan coping keluarga sehingga dapat membentuk efikasi diri yang baik dalam anggota keluarga.

4. Tahap kolaborasi (Collaborative phase). Keluarga mulai menjadi lebih percaya diri melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan menata ulang tanggungjawab terhadap kondisi sakit kronis pada anggota keluarganya. Kolaborasi yang dilaksanakan membantu proses evaluasi perkembangan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam keluarga.



Gambar 2.1. Kerangka FCEM

D. Ruang lingkup dan tujuan FCEM

Ruang lingkup pemberdayaan berpusat pada keluarga meliputi aspek-aspek ketahanan keluarga, fungsi, peran dan tugas perkembangan keluarga, sumber daya keluarga, pengelolaan masalah dan stress keluarga, interaksi dan komunikasi keluarga, serta tipologi keluarga dan ketahanan keluarga (*Family resilience*) [16]. Adapun tujuan model pemberdayaan berpusat pada keluarga yaitu:

1. Membantu keluarga untuk menerima, melewati dan mempermudah proses perubahan dalam keluarga.
2. Membangun adaptasi yang tinggi terhadap perubahan dalam mengatasi hambatan yang berarti.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh anggota keluarga sesuai tahap perkembangan keluarga
4. Menggali kapasitas atau potensi tersembunyi anggota keluarga
5. Membina dan mendampingi proses perubahan dan menciptakan kemandirian keluarga.

E. Prinsip-prinsip FCEM

Penerapan *Family Centered Empowerment Model (FCEM)* dalam konteks keperawatan keluarga harus memperhatikan prinsip-prinsip agar pemberdayaan keluarga dapat terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip ini akan membimbing cara pendekatan yang efektif mendukung keluarga agar dapat berperan lebih aktif dalam perawatan dan pengawasan kesehatan anggota keluarga, terutama untuk anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Berikut adalah prinsip-prinsip utama proses untuk melakukan pemberdayaan keluarga:

1. Partisipasi aktif keluarga

Partisipasi keluarga dalam seluruh proses pengambilan keputusan kesehatan sangat penting. Dalam aspek partisipasi ini, keluarga bukan hanya penerima informasi atau instruksi dari tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengobatan. Misalnya, dalam pengobatan anak, orang tua atau wali memiliki peran utama dalam memastikan anak mengikuti terapi yang direkomendasikan. Dalam model ini, tenaga kesehatan (perawat/dokter) tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mendengarkan pendapat dan kekhawatiran keluarga. Dengan demikian, keluarga merasa dihargai dan lebih berkomitmen terhadap kesuksesan pengobatan yang dijalani oleh anak.

2. Kolaborasi antara keluarga dan tenaga kesehatan.

Pendekatan berbasis kemitraan antara keluarga dan tenaga kesehatan merupakan hal yang krusial. Kolaborasi ini mengakui bahwa keluarga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang gambaran kondisi kesehatan anak atau anggota keluarga lainnya, sedangkan tenaga kesehatan memiliki pengetahuan klinis penyakit. Dengan menggabungkan keduanya, keluarga dapat berperan aktif dalam perawatan dan pengobatan. Kolaborasi ini mencakup komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan berbagi tanggung jawab dalam pemantauan kesehatan. Keluarga dan tenaga kesehatan bersama-sama menentukan rencana perawatan, memantau progres pengobatan, dan mengatasi masalah yang muncul sepanjang jalannya pengobatan.

3. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan keluarga

Pemberdayaan keluarga juga berarti memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merawat dan mendukung anggota keluarga yang sakit. Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan dalam keluarga yang penting adalah berupa edukasi kesehatan yang diberikan kepada keluarga. Misalnya, dalam kasus pengawasan minum obat anak, keluarga perlu memahami manfaat obat, dosis yang tepat, efek samping yang mungkin terjadi, cara memastikan anak mengonsumsi obat sesuai jadwal.

Edukasi ini dapat diberikan melalui berbagai metode, seperti pelatihan langsung oleh perawat, materi edukasi tertulis, atau penggunaan media digital. Selain itu, keluarga harus dilibatkan dalam proses pelatihan keterampilan seperti bagaimana cara memantau kondisi kesehatan anak, mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi, dan mengambil tindakan yang diperlukan.

4. Kepekaan terhadap nilai, budaya, dan kebiasaan kesehatan keluarga.

Setiap keluarga memiliki nilai-nilai, budaya, dan tradisi kesehatan yang berbeda-beda. Dalam proses pemberdayaan, penting bagi perawat untuk menghormati dan menyesuaikan pendekatan dengan latar belakang budaya dan nilai-nilai tersebut. Ini termasuk memperhatikan cara-cara keluarga memahami kesehatan, pengobatan, dan peran keluarga dalam proses penyembuhan. Perawat yang peka terhadap nilai-nilai keluarga dapat menciptakan hubungan yang lebih saling percaya dan menghargai, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam pengobatan. Misalnya, dalam beberapa budaya di keluarga, ada

pengaruh yang kuat terhadap keputusan medis yang diambil oleh anggota keluarga. Menghargai struktur ini penting agar keluarga merasa didukung, bukan diminta untuk mengikuti pendekatan yang tidak sesuai dengan kepercayaan keluarga.

5. Fokus pada kekuatan keluarga (*family strengths*)

Model pemberdayaan berpusat pada keluarga lebih menekankan aspek kekuatan keluarga daripada kelemahan atau masalah yang ada di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses perawatan kesehatan, meskipun terkadang keluarga menghadapi tantangan kesehatan yang besar. Dengan memfokuskan pada kekuatan keluarga, perawat mampu mengakui bahwa setiap keluarga memiliki kapasitas untuk beradaptasi, belajar, dan berkembang. Misalnya, beberapa keluarga mungkin memiliki kekuatan dalam komunikasi yang baik, sementara keluarga lainnya mungkin unggul dalam menciptakan lingkungan yang penuh dukungan emosional. Selanjutnya, perlu memahami dan memperkuat kekuatan ini agar dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki hasil kesehatan.

F. Contoh Penerapan FCEM dalam Praktik

Penerapan *Family Centered Empowerment Model (FCEM)* dalam pengawasan minum obat anak dapat dilakukan dalam berbagai tempat baik di tingkat komunitas maupun fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit. Model ini bertujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan keluarga, tetapi juga menciptakan perubahan sikap dan keterampilan yang mendukung pengobatan jangka panjang.

1. Studi Kasus di Komunitas: Pemberdayaan Keluarga dalam Pengobatan TBC Anak

a. Latar Belakang:

Di sebuah wilayah padat penduduk di pinggiran kota, ditemukan angka kejadian tuberkulosis (TBC) anak yang cukup tinggi. Banyak anak yang tidak menyelesaikan terapi selama 6 bulan karena ketidaktahuan keluarga, efek samping obat, serta rendahnya dukungan psikososial.

b. Intervensi:

- 1) Dinas kesehatan setempat bekerja sama dengan puskesmas dan kader kesehatan untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga.
- 2) Keluarga diberikan pelatihan singkat tentang: Siklus hidup TBC, Pentingnya terapi jangka panjang, Teknik pencatatan minum obat harian (kartu PMO), Cara menangani efek samping ringan.

c. Pendekatan yang digunakan:

- 1) Pendidikan kelompok: Sesi edukatif berkala bersama keluarga pasien lainnya.
- 2) *Home visit* (kunjungan rumah) oleh kader: Memantau kepatuhan dan memberi dukungan emosional.
- 3) Penggunaan alat pengingat (*reminder manual*): Kalender pengobatan ditempel di rumah.

d. Hasil:

- 1) Peningkatan angka penyelesaian terapi hingga 90%.

- 2) Keluarga lebih percaya diri menghadapi efek samping dan dapat memberi penjelasan kepada anak.
 - 3) Komunikasi antara keluarga dan tenaga kesehatan meningkat secara signifikan.
2. Studi Kasus di Rumah Sakit: FCEM pada Anak Epilepsi
- a. Latar Belakang:

Seorang anak usia 7 tahun dengan epilepsi datang ke rumah sakit anak karena sering kambuh akibat ketidakpatuhan minum obat. Orang tua merasa bingung dengan dosis obat yang berubah-ubah dan malu untuk bertanya lebih lanjut.

Intervensi:
 - b. Tim perawat melaksanakan pendekatan FCEM dengan tahapan:
 - 1) Identifikasi masalah keluarga (kebingungan soal obat dan efek samping).
 - 2) Pemberian edukasi visual dan praktik langsung dalam pemberian obat.
 - 3) Membuat rencana perawatan bersama keluarga, termasuk: Jadwal harian pengobatan, Strategi mengingatkan anak, dan Cara mencatat frekuensi kejang.
 - 4) Follow-up melalui telepon pasca rawat jalan.
 - c. Hasil:
 - 1) Frekuensi kejang menurun drastis.
 - 2) Orang tua merasa lebih percaya diri dan aktif berdiskusi dalam kontrol rutin.
 - 3) Anak mulai kooperatif minum obat karena pendekatan orang tua lebih suportif.

3. Penggunaan media dan teknologi sebagai alat pendukung FCEM
 - a. Aplikasi pemantauan obat: Beberapa komunitas telah menggunakan aplikasi sederhana untuk mengingatkan waktu minum obat anak (misalnya: Medisafe, SehatQ).
 - b. *WhatsApp Group* Edukatif: Kelompok orang tua dengan anak yang memiliki kondisi serupa, difasilitasi oleh perawat komunitas, menjadi tempat berbagi dan belajar.
 - c. Video edukasi singkat: Diputar di ruang tunggu rumah sakit atau dikirim ke ponsel keluarga pasien, yang menjelaskan cara pemberian obat dan menangani efek samping.
4. Faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan model
 - a. Komunikasi dua arah yang baik antara tenaga medis dan keluarga
 - b. Komitmen tenaga kesehatan untuk melibatkan keluarga dalam proses perawatan
 - c. Ketersediaan media edukatif yang sesuai budaya dan bahasa lokal
 - d. Konsistensi dalam pemantauan dan umpan balik kepada keluarga

G. REFERENSI

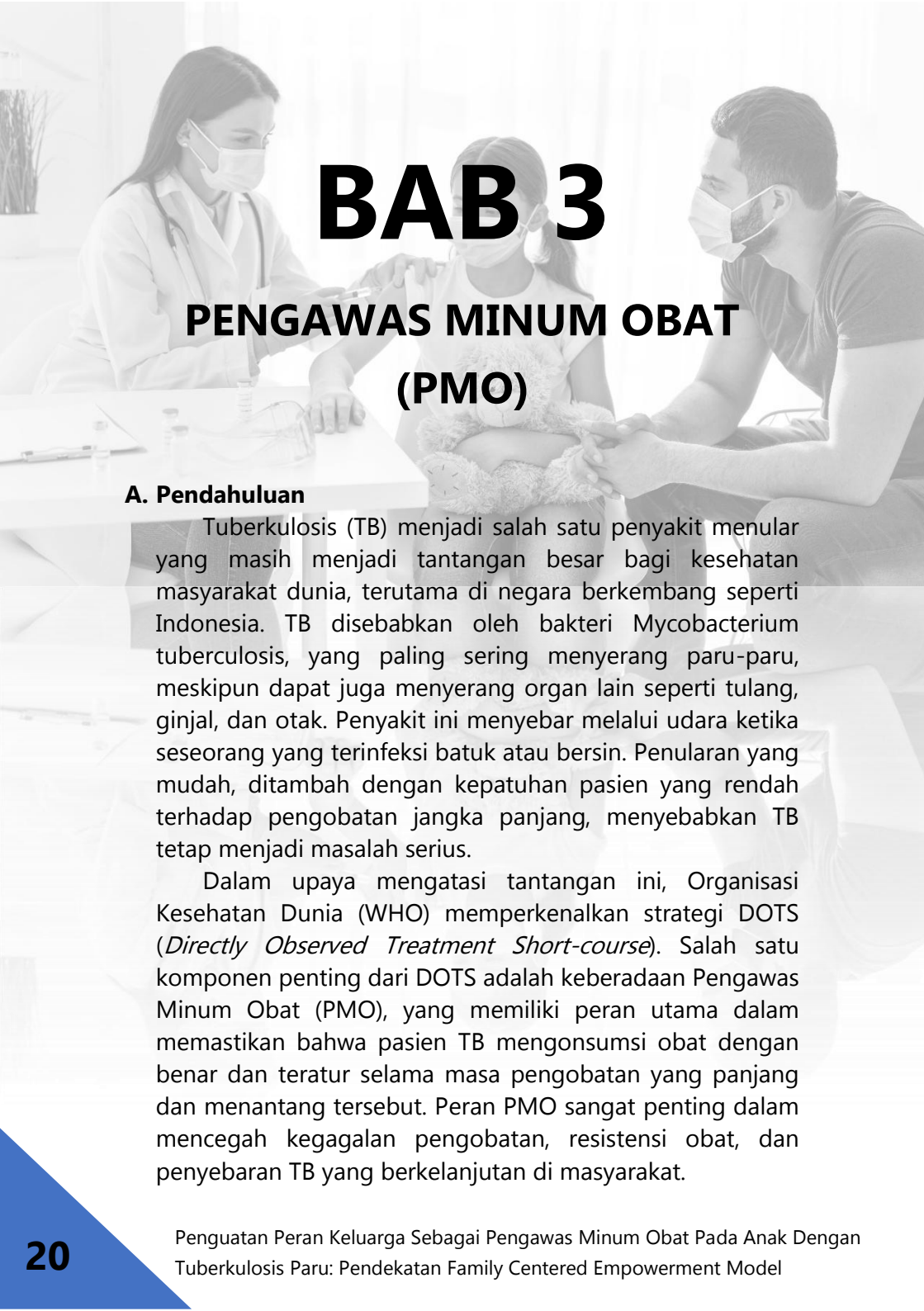
- Anderson, E. T., & Mcfarlane, J. (2016). *Community As Patner Theory and Practice in Nursing* (7th ed.). Wolter Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins
- Friedman, L. M. (2015). *Buku ajar keperawatan keluarga: riset, teori, praktik* (5thed). Jakarta: EGC
- Nies, M., & Mc Ewen, M. (2018). *Community Public Health Nursing: Promoting The Health of Population* (7 th). Elsevier Inc.

- Kemenkes RI. (2022). Tuberculosis prevention and control comunitable diseases. Badan Pencegahan Pengendalian Penyakit: Jakarta
- Kemenkes RI. (2023). Program penanggulangan tuberkulosis. Badan Pencegahan Pengendalian Penyakit: Jakarta
- Patriani A, Paramastri I, Priyanto M. (2017). Pemberdayaan Keluarga Dalam Rehabilitasi Medik Paru Pada Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik di Balai Pengobatan Penyakit Paru Yogyakarta.
- Isbaniah, F., Burhan. E, Sinaga. B.Y.M., Yanifitri. B.H, Handayani. D., dkk. (2021). Panduan dan diagnosis penatalaksanaan Tuberkulosis di Indonesia. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI): Jakarta.
- Ibrahim, G.A., Ismadi. H.D., Zabadi. F., Ali. N.B.V., Alipi. M., Antoro. B., Hanifah. N., Miftahussurari, Nento. M.N., Akbari. Q.S & Aziz. M. (2017). Peta Jalan gerakan literasi nasional. Kementerian Pendidikan dan Kabadayaan
- Sovia dkk. (2023). Bunga Rampai Keperawatan Keluarga. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.
- Puspasari, Maria Elena. (2017). Pembentukan Ruang Virtual Medai Interaktif dalam Proses Edukasi. Jurnal Creativitas. 3(2):347-357.
- Wenno, S.Z., Kolompoy dkk. (2023). Keperawatan komunitas dan kesehatan masyarakat Jilid 1. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.
- Nurhaliza. W.O.S dan Fauziah. N. (2020). Komunikasi Kelompok dalam Virtual Community. Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah. 10(01); 18-38;

DOI:10.35905/komunida.v7i2.

<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/index>

- Sovia dkk. (2023). Bunga Rampai Keperawatan Keluarga. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.
- Erlinda, V., & Kunci, K. (2015). Application Of Family-Centered Nursing Model On The Execution Of Family Health Care In Preventing Acute Respiratory Tract Infection Of Under 5 Years Children In The Working Area Of Simpang Tiga Public Health Center Aceh. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 23(2), 165–186.
- Kashaninia, Z., Payroovee, Z., Soltani, R., & Mahdaviani, S. A. (2018). Effect of Family Empowerment on Asthma Control in. *Tanaffos*, 17(1), 47–52.
- Moattari, M., Ebrahimi, M., Sharifi, N., & Rouzbeh, J. (2012). The effect of empowerment on the self-efficacy, quality of life and clinical and laboratory indicators of patients treated with hemodialysis: A randomized controlled trial. *Health and Quality of Life Outcomes*, 10, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-10-115>
- Wacharasin, C., Phaktoop, M., & Sananreangsak, S. (2015). A family empowerment program for families having children with thalassemia, Thailand. *Nursing and Health Science*, 17(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nhs.12201>



BAB 3

PENGAWAS MINUM OBAT (PMO)

A. Pendahuluan

Tuberkulosis (TB) menjadi salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. TB disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang paling sering menyerang paru-paru, meskipun dapat juga menyerang organ lain seperti tulang, ginjal, dan otak. Penyakit ini menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan yang mudah, ditambah dengan kepatuhan pasien yang rendah terhadap pengobatan jangka panjang, menyebabkan TB tetap menjadi masalah serius.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkenalkan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*). Salah satu komponen penting dari DOTS adalah keberadaan Pengawas Minum Obat (PMO), yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pasien TB mengonsumsi obat dengan benar dan teratur selama masa pengobatan yang panjang dan menantang tersebut. Peran PMO sangat penting dalam mencegah kegagalan pengobatan, resistensi obat, dan penyebaran TB yang berkelanjutan di masyarakat.

B. Pengertian dan Peran PMO

PMO adalah individu yang bertugas mengawasi secara langsung proses konsumsi obat oleh pasien TB setiap hari selama masa pengobatan. Tugas PMO tidak hanya sekadar menyaksikan pasien menelan obat, tetapi juga mencatat kehadiran, memberikan motivasi, dan melaporkan efek samping atau masalah kepada tenaga kesehatan.

PMO juga disebut sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan penderita TB paru minum obat secara rutin sesuai jadwal selama masa pengobatan TUNTAS TB (selama 6 bulan). Adapun kriteria seseorang yang dapat menjadi PMO adalah orang tua atau anggota keluarga dekat, guru atau wali yang tinggal serumah dengan pasien TB paru, serta petugas kesehatan atau kader TB.

Pengobatan TB memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu minimal enam bulan untuk kasus TB sensitif obat. Dalam periode yang panjang ini, banyak pasien mengalami kejenuhan, kelelahan, atau merasa sudah sembuh sebelum pengobatan selesai, sehingga berhenti minum obat. Hal inilah yang menjadi penyebab utama munculnya kasus TB yang resisten obat (MDR-TB) yang jauh lebih sulit dan mahal untuk diobati. PMO hadir untuk mencegah hal tersebut dengan memberikan dukungan yang bersifat langsung dan konsisten.

C. Tujuan dan Manfaat PMO

Tujuan utama dari keterlibatan PMO adalah untuk menjamin bahwa pasien:

1. Minum obat sesuai dosis dan jadwal.\
2. Tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya.
3. Menerima dukungan moral dan edukasi mengenai TB.
4. Meningkatkan angka kesembuhan pasien TB.
5. Mengurangi risiko penularan TB di masyarakat
6. Mencegah munculnya MDR-TB dan kasus TB kambuh.
7. Mempermudah petugas kesehatan dalam memantau kepatuhan pasien.

D. Kriteria dan Karakteristik PMO yang Efektif

PMO yang baik harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

1. Bertempat tinggal dekat dengan pasien atau berada dalam satu lingkungan komunitas.
2. Bersedia mendampingi pasien setiap hari selama masa pengobatan.
3. Dapat membaca dan menulis agar mampu mencatat jadwal minum obat.
4. Disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

Karakteristik tambahan yang diharapkan dari seorang PMO adalah empati tinggi, mampu berkomunikasi secara baik dengan pasien, dan tidak menstigma penderita TB. PMO juga idealnya merupakan orang yang sudah dikenal dan dipercaya pasien, seperti anggota keluarga, kader kesehatan, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.

E. Tugas dan Tanggung Jawab PMO secara Rinci

Tugas PMO sangat luas dan tidak hanya berfokus pada pengawasan konsumsi obat. Beberapa tanggung jawab penting meliputi:

1. Menyaksikan langsung pasien menelan obat setiap hari.

Yang harus dilakukan adalah mengingatkan dan memastikan penderita TB paru minum obat sesuai dengan jadwal agar penderita patuh menjalani pengobatannya

2. Mencatat konsumsi obat harian dalam buku catatan PMO.

Seorang PMO harus membuat catatan harian terkait jumlah, dosis, waktu, cara pemberian obat untuk mendukung keberhasilan pengobatan DOTS

3. Mengingatkan pasien akan pentingnya minum obat secara rutin.

PMO dapat memberikan motivasi dan menemani saat pasien ingin meminum obatnya setiap hari

4. Mendeteksi gejala efek samping obat dan segera melaporkannya.

Efek samping obat TB dapat muncul dengan berbagai keluhan dari penderita seperti mual muntah, nafsu makan menurun, warna urin kemerahan, alergi di kulit, nyeri sendi, maka PMO bisa memberikan pencegahan dari efek tersebut.

5. Menjadi penghubung antara pasien dan fasilitas kesehatan.

PMO dapat berkoordinasi dengan petugas kesehatan saat mengantar pasien mengambil obat ke puskesmas.

6. Memberikan edukasi kepada pasien mengenai TB dan pentingnya pengobatan sampai tuntas.

PMO juga dapat memberikan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh penderita selama pengobatan DOTS berlangsung

7. Memberikan dukungan emosional kepada pasien agar tidak putus asa.

Dukungan emosional dapat berupa penghargaan diri dan motivasi diri kepada pasien baik sebelum, saat maupun setelah penderita minum obat setiap harinya.

F. Strategi Implementasi PMO dalam Program DOTS

DOTS mengandalkan integrasi antara sistem pelayanan kesehatan dan peran komunitas. Oleh karena itu, keterlibatan PMO sebagai wakil dari komunitas sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Berikut strategi implementasi PMO dalam program DOTS :

1. Pelatihan PMO oleh tenaga kesehatan mengenai cara kerja, pencatatan, serta pengetahuan dasar TB.
2. Penentuan PMO secara kolaboratif antara pasien, keluarga, dan petugas kesehatan.
3. Monitoring dan evaluasi rutin oleh Puskesmas atau klinik terhadap pelaksanaan tugas PMO.

G. Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas PMO

PMO perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, insentif bagi PMO, serta peningkatan edukasi masyarakat agar peran PMO lebih dihargai dan efektif. Meskipun penting, PMO sering menghadapi tantangan seperti:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang TB dan pentingnya peran PMO.
2. Stigma terhadap pasien TB yang menyulitkan keterlibatan PMO dari luar keluarga.
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya bagi PMO, terutama jika dilakukan secara sukarela.

4. Ketidapatuhan pasien meskipun telah diawasi.
5. Penderita Tb sulit menerima dan minum obat
6. PMO kurang memahami pentingnya disiplin pengobatan
7. Adanya efek samping yang membuat penerima malas minum obat.

H. Strategi agar tugas PMO berhasil

Peran PMO sangat penting dalam pengendalian TB, khususnya dalam strategi DOTS. Keberhasilan pengobatan TB sangat bergantung pada kepatuhan pasien, dan PMO memainkan peran sentral dalam menjamin hal tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas PMO, perlu adanya pelatihan, dukungan, dan penghargaan atas kontribusi mereka. Pemerintah dan sektor kesehatan harus terus mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan PMO agar target eliminasi TB nasional dapat tercapai.

Strategi agar tugas Pmo berhasil dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

1. Pendekatan bagi penderita
 - a. Menyediakan Peningkat: Pasang alarm atau buat jadwal visual yang menarik
 - b. Memotivasi dengan bahasa sederhana bahwa obat akan membantu kondisi tubuh cepat sembuh
 - c. Ceritakan pengalaman/kisah / dongeng tentang keberanian melawan penyakit
 - d. Mencampur obat dengan makanan/ minuman yang disukai (jika diperbolehkan)
 - e. Memberikan hadiah kecil atau pujian setiap kali berhasil minum ob
2. Dukungan bagi orang tua

- a. Tunjukkan peran orang tua / keluarga penting dalam kesembuhan
- b. Gunakan cara yang menyenangkan mengingatkan jadwal minum obat (Lagu, permainan, alarm ponsel, catatan harian)
- c. Libatkan anggota keluarga lain dalam edukasi kesehatan TB paru di puskesmas jika memungkinkan

I. REFERENSI

CDC. Tuberculosis in Children [Internet]. (2025). Available from: https://www.cdc.gov/tb/about/children.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/tb/topic/populations/tbinchildren/default.htm

WHO. Tuberculosis [Internet]. (2024). Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis#:~:text=1. A total of 1.25 million>

Kemkes. (2024). Kasus TBC Tinggi Karena Perbaikan Sistem Deteksi dan Pelaporan [Internet]. 29 Januari 2024. p. 1–27. Available from: <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/kasus-tbc-tinggi-karena-perbaikan-sistem-deteksi-dan-pelaporan%0Ahttps://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240129/2644877/kasus-tbc-tinggi-karena-perbaikan-sistem-deteksi-dan-pelaporan/#:~:text=Komitme>

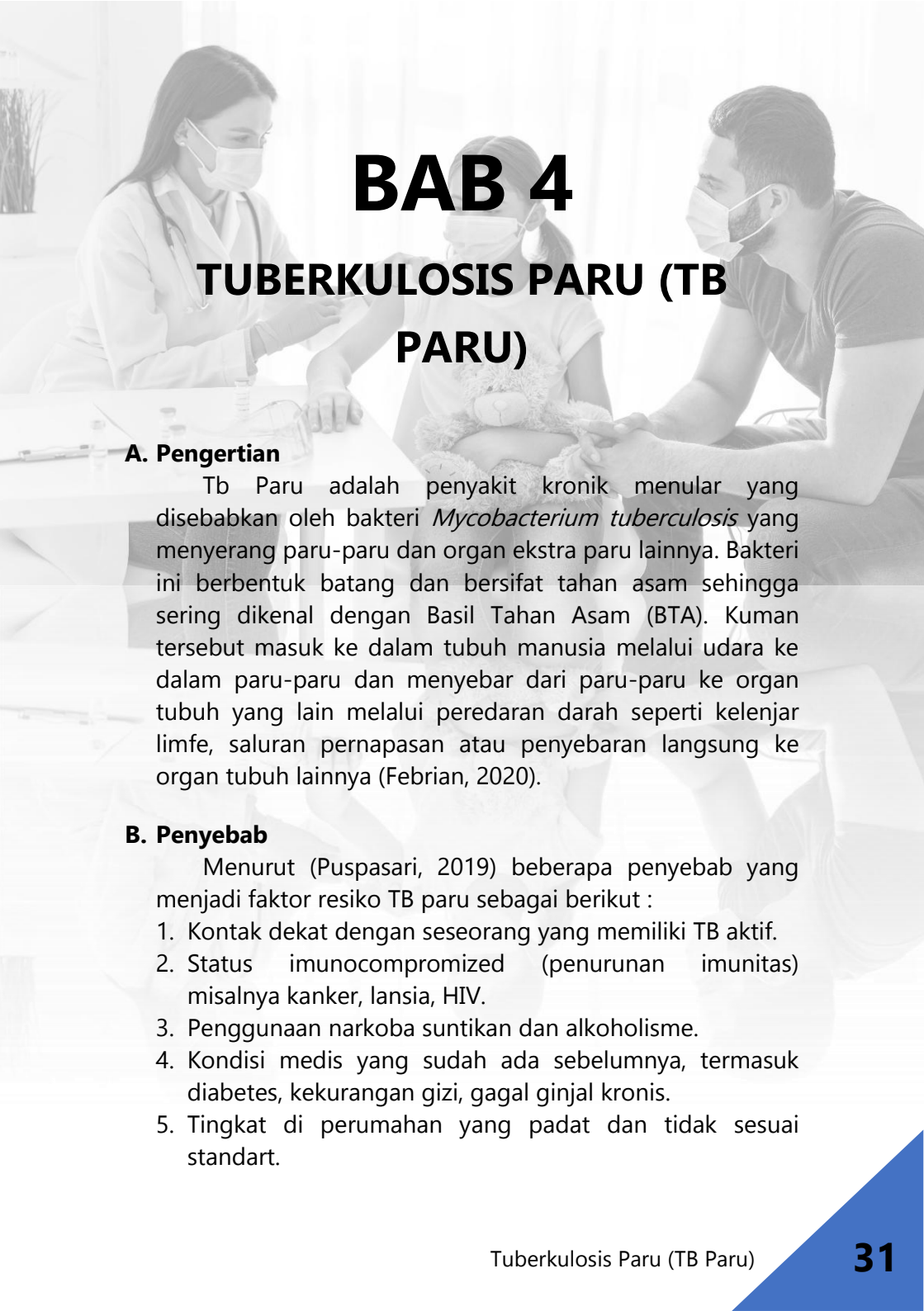
- Manurung N, Harahap RH, Siregar FA, Andayani LS.(2022). Family Support in Increasing Adherence To Treatment of Tuberculosis Patients. *Seybold Rep*;1276–84.
- KNCV YI. (2024). Mengenal TBC RO pada Anak dan Permasalahannya [Internet]. Available from: <https://yki4tbc.org/mengenal-tbc-ro-pada-anak-dan-permasalahannya/>
- Allender JA, Rector C, Warner KD. (2010). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. *Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health*. p. 413–4.
- Shoghi M, Shahbazi B, Seyedfatemi N. (2019). The Effect of the Family-Centered Empowerment Model (FCEM) on the Care Burden of the Parents of Children Diagnosed with Cancer. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2(6):1757–64.
- Kristinawati B, Muryadewi A, Irianti AD. (2019). The Role of Family as A Caregiver in Caring for Family Members that are Suffering from Pulmonary Tuberculosis. *J Ners*.14(3 Special Issue):362–6.
- Friedman MM, Bowden VR, Jones EG. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, & Praktik*. V. Tiar E, editor. Jakarta: EGC

- WHO. (2024). Nutritional care for children and adolescents with TB [Internet]. Available from: <https://tbksp.who.int/en/node/2104>
- Gao L, Luo B. (2024). Assessment of Factors Associated With Anti-Tubercular Treatment Compliance in Children: A Cross-Sectional Study. *Glob Pediatr Heal*. 11:2333794X231199360.
- Goffman E. (2021). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. USA: Prentice- Hall Inc.;
- Astuti VW, Nursasi AY, Sukihananto S. 2019). Structured Health Education And Community Stigma In Lung TB Clients. *JPP (Journal Heal Poltekkes Palembang)*. 14(2):85–90.
- Melati A, Rohmatin T, Putri Karina G, Asri T, Apriani D, Rakhmawati W. (2023). Parent's Stigma Towards Childhood Tuberculosis: A Multicenter Survey from Eastern Bandung Regency. *J Keperawatan Komprehensif (Comprehensive Nurs Journal)*. 9(3):13-23.
- Wati, Ana. (2024). Pendampingan Kepada Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengobatan Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Haliwen. *JIKIN* 8(1):13–22.
- WHO. (2023). Social support in TB management [Internet]. Available from: <https://tbksp.who.int/en/node/2315#:~:text=2>

Suitable treatment administration options,for decision-making and reminders.

- Amigo.(2012). Hubungan karakteristik dan pelaksanaan Tugas perawatan Kesehatan keluarga dengan status Kesehatan pada angregater lansia dengan Hipertensi di kecamatan jetis. Yogyakarta: Tesis, UI.
- Friedman, M.M., Bowden, V,R., & Jones, EG. (2010). Family Nursing: Research, Theory & Practice. New Jersey : Pearson Education. Inc
- Ikatan perawat kesehtan komunitas Indonesia (IPKKI). (2007). Panduan Asuhan Keperawatan; individu, keluarga, kelompok dan komunitas dengan modifikasi NANDA, ICNP, NOC dan NIC di Puskesmas dan Masyarakat. Jakarta: UI-press.
- Kaakinen, J.R., Coehlo, D,P., Steele, R., & Robinson, M. (2018). Family Health Care Nursing : Theory, Practice And Research. Sixth Edition. Philadelphia : F.A. Davis Company.
- Kaakinen Jr and Birenbaum, RK (2017). Family Development and Family Nursing Assessment <https://nursekey.com/family-development-and-family-nursing-assessment/>
- Kaakinen, J.R., Gedaly-Duff, V., Coehlo, D.P., & Hanson, S.M.H. (2013). Family Health Care Nursing : Theory, Practice And Research. Philadelphia : F.A. Davis Company.

- Kemenkes RI (2019). Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta : Sekretarian Jenderal Kementerian Kesehatan.
- Kholifah, S.N & Widagdo, W. (2016). Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.
<http://bppsdmk.kemkes.go.id>.
- Setiawan, Ridwan. (2016). Teori & Praktek Keperawatan Keluarga. Semarang. UNNEs Press.
- Anggraini, D., & Kumala, O. (2022). Diare Pada Anak. *Scientific Journal*, 1(4), 309–317.
<https://doi.org/10.56260/sciena.v1i4.60>
- Dianti, Y. (2023). Keperawatan keluarga. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Has, E. M. M., Ulfiana, E., Krisnana, I., Arief, Y. S., Mufidah, A., & Fathoni, M. (2020). Program Pagar Besi (Pendampingan Keluarga Sadar Dan Siaga Tuberkulosis Paru) Untuk Mencapai Zero Tb Case 2020 Di Wilayah Kerja Puskesmas Klampis Ngasem, Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dalam Kesehatan*, 2(2), 36.
<https://doi.org/10.20473/jpmk.v2i2.20798>



BAB 4

TUBERKULOSIS PARU (TB PARU)

A. Pengertian

Tb Paru adalah penyakit kronik menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang paru-paru dan organ ekstra paru lainnya. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga sering dikenal dengan Basil Tahan Asam (BTA). Kuman tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara ke dalam paru-paru dan menyebar dari paru-paru ke organ tubuh yang lain melalui peredaran darah seperti kelenjar limfe, saluran pernapasan atau penyebaran langsung ke organ tubuh lainnya (Febrian, 2020).

B. Penyebab

Menurut (Puspasari, 2019) beberapa penyebab yang menjadi faktor resiko TB paru sebagai berikut :

1. Kontak dekat dengan seseorang yang memiliki TB aktif.
2. Status imunocompromized (penurunan imunitas) misalnya kanker, lansia, HIV.
3. Penggunaan narkoba suntikan dan alkoholisme.
4. Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, termasuk diabetes, kekurangan gizi, gagal ginjal kronis.
5. Tingkat di perumahan yang padat dan tidak sesuai standart.

6. Pekerjaan misalnya petugas pelayanan kesehatan.
7. Orang yang kurang mendapat perawatan kesehatan yang memadai misalnya tunawisma atau miskin.

C. Tanda dan Gejala

1. Gejala Respiratorik :
 - a. Batuk kering yang berangsur-angsur menjadi produktif lebih dari 3 minggu, kadang-kadang bercampur dengan dahak
 - b. Sesak napas
 - c. Nyeri dada
2. Gejala Sistemik:
 - a. Demam terutama di malam hari
 - b. Berkeringat dingin malam hari tanpa aktivitas atau sebab yang jelas
 - c. Penurunan nafsu makan
 - d. Penurunan berat badan
 - e. Kelelahan

D. Klasifikasi

Penyakit tuberkulosis dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Puspasari, 2019):

1. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit :
 - a. Tuberkulosis paru TB yang terjadi pada parenkim (jaringan) paru. Milier TB dianggap sebagai TB paru karena adanya lesi pada jaringan paru.
 - b. Tuberkulosis ekstra paru TB yang terjadi pada organ selain paru misalnya kelenjar limfe, pleura, abdomen, saluran kencing, kulit, selaput otak, sendi dan tulang
2. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya:

- a. Klien yang belum pernah mendapatkan pengobatan TB paru sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT namun kurang dari satu bulan (< 28 dosis).
- b. Klien yang pernah diobati TB: klien yang sebelumnya pernah menelan OAT selama satu bulan atau lebih (≥ 28 hari).
- c. Klien berdasarkan hasil pengobatan TB terakhir, yaitu :
 - 1) Klien kambuh: klien TB paru yang pernah dinyatakan sembuh dan saat ini didiagnosis TB berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologi
 - 2) Klien yang diobati kembali setelah gagal: klien TB paru yang pernah diobati dan gagal pada pengobatan terakhir.
 - 3) Klien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to followup): klien TB paru yang pernah diobati dan dinyatakan lost to follow-up (dikenal sebagai pengobatan klien setelah putus berobat).
 - 4) Lain-lain: klien TB paru yang pernah diobati tetapi hasil akhir pengobatan sebelumnya tidak diketahui.
3. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat:

Pengelompokkan penderita TB berdasarkan hasil uji kepekaan contoh uji dari mycobacterium tuberculosis terhadap OAT:

- a. Mono resisten (TB MR)
- b. Poli resisten (TB PR)
- c. Multidrug resisten (TB MDR)
- d. Extensive drug resisten (TB XDR)
- e. Klasifikasi penderita TB berdasarkan status HIV:
 - 1) Klien TB dengan HIV positif
 - 2) Klien TB dengan HIV negative
 - c) Klien TB dengan status HIV tidak diketahui

E. Patofisiologi

Patofisiologi tuberkulosis paru atau TBC paru disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium tuberculosis* yang menular melalui aerosol dari membran mukosa paru-paru individu yang telah terinfeksi. Ketika seseorang dengan TB paru yang aktif batuk, bersin, atau meludah, droplet akan keluar ke udara bebas. Ketika terinhalasi oleh individu lain, droplet infeksius akan terkumpul di paru-paru dan organisme akan berkembang dalam waktu 2–12 minggu.

Individu terinfeksi melalui droplet nuclei dari pasien TB paru ketika pasien batuk, bersin, tertawa. Droplet nuclei ini mengandung basil TB dan ukurannya kurang dari 5 mikron dan akan melayang-layang di udara. Droplet nuclei ini mengandung basil TB. Saat *Mikrobacterium Tuberkulosa* berhasil menginfeksi paru-paru maka dengan segera akan tumbuh koloni bakteri yang berbentuk globular. Biasanya melalui serangkaian reaksi imunologis, bakteri TB paru ini akan berusaha dihambat melalui pembentukan dinding di sekeliling bakteri itu oleh sel-sel paru. Mekanisme pembentukan dinding itu membuat jaringan di sekitarnya menjadi jaringan parut dan bakteri TB paru akan menjadi dormant (istirahat). Bentuk-bentuk dormant inilah yang sebenarnya terlihat sebagai tuberkel pada pemeriksaan foto rontgen.

Sistem imun tubuh akan berespon dengan melakukan reaksi inflamasi. Fagosit (neutrofil dan makrofag) menelan banyak bakteri; limpospesifik-tuberkulosis melisis (menghancurkan) basil dan jaringan normal. Reaksi jaringan ini mengakibatkan penumpukan eksudat dalam alveoli, yang menyebabkan bronkopneumonia dan infeksi awal terjadi dalam 2-10 minggu setelah pemajanan. (Ice D 2018)

F. Komplikasi

1. Kerusakan Otak (Meningeal Tuberculosis)

TBC adalah penyakit yang menular melalui udara dan biasanya berimbas pada paru-paru. Bila tidak ditangani segera, bakteri yang menyebabkan penyakit ini dapat mengalir pada aliran darah sehingga dapat merusak organ tubuh yang lain. Terkadang, bakteri ini akan berpindah ke sekeliling otak dan cincin tulang belakang (meninges). Inilah yang disebut dengan meningeal tuberculosis. Komplikasi yang terjadi pada otak ini bisa menyebabkan hilangnya kemampuan mendengar, meningkatkan tekanan pada otak (intracranial pressure), kerusakan otak, stroke, dan bahkan kematian.

2. Pneumothorak (adanya udara di dalam rongga pleura) spontan : kolaps spontan karena kerusakan jaringan paru.
3. Bronki ektasis (pelebaran bronkus setempat) dan fibrosis (pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif) di paru.
4. Penyebaran infeksi keorgan lainnya seperti otak, tulang, persendian, ginjal dan sebagainya.
5. Insufisiensi kardiopulmonal (Chardio Pulmonary Insufficiency).
6. Hemoptisis berat (pendarahan pada saluran nafas bawah) yang mengakibatkan kematian karena terjadinya syok hipovolemik atau tersumbatnya jalan pernafasan

G. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah :

1. Pemeriksaan Radiologi: Gambaran thorax menunjukkan adanya lesi berupa infiltrat, fibroinfiltrat/ fibrosis, konsolidasi/ kalsifikasi, tuberkuloma, dan kavitas
2. Bronchografi: Merupakan pemeriksaan khusus untuk melihat kerusakan bronchus atau kerusakan paru karena TB.
3. Laboratorium:
 - a. Darah: leukositosis/ leukopenia, LED meningkat
 - b. Sputum: BTA S/P/S, kultur sputum gram sensitivity, sputum media LJ, DST, GeneXpert
 - c. Test Tuberkulin: Mantoux test (indurasi lebih dari 10-15 mm)

Saat ini uji kepekaan *M. tuberculosis* secara tepat (rapid test) sudah direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan sebagai penampisan. Metode yang tersedia adalah:

- 1) Line probe assay (LPA): Pemeriksaan molekuler yang di dasarkan pada PCA. Dikenal dengan Hain test/ Genotype MDRTB plus. Hasil pemeriksaan dapat di peroleh dalam waktu kurang lebih 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari *M. tuberculosis* yang resisten terhadap rifampisin (R) ternyata juga resisten terhadap isoniazid (H) sehingga tergolong MDR
- 2) Gene-Xpert Hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 1-2 jam

H. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan tuberkulosis paru atau TBC paru dilakukan secara farmakologis dengan pemberian obat antituberkulosis atau OAT, misalnya isoniazid, rifampisin,

pirazinamid, dan etambutol (Alomedika Caroline ODP 2020). Kombinasi obat-obat ini dikonsumsi secara teratur dan diberikan dalam jangka waktu yang tepat meliputi tahap awal dan tahap lanjutan.

1. Medikamentosa Tuberkulosis Paru Aktif

Pada tahap awal (fase intensif), obat diberikan tiap hari selama 2 bulan, yakni berupa kombinasi isoniazid, rifampisin, pirazinamid, dan etambutol. Lalu, pada tahap lanjutan, obat diberikan tiap hari selama 4 bulan, yakni berupa isoniazid dan rifampisin.

2. Medikamentosa Tuberkulosis Paru yang Resisten

TB paru yang resisten obat disebabkan oleh bakteri tuberkulosis yang resisten terhadap minimal satu regimen obat lini pertama tuberkulosis. Multidrug-resistant TB (MDR-TB) adalah kasus TB yang resisten terhadap > 1 OAT, yang meliputi isoniazid dan rifampisin.

3. Evaluasi Terapi Tuberkulosis Paru Aktif

Pasien dalam terapi TB paru perlu menjalani evaluasi berkala untuk menilai respons terhadap terapi OAT. Pemeriksaan sputum basil tahan asam (BTA) dilakukan pada akhir fase intensif. Sputum BTA yang positif pada akhir fase intensif dapat mengindikasikan dosis OAT yang kurang, kepatuhan minum obat yang buruk, adanya komorbiditas, atau adanya resistensi terhadap obat lini pertama.

4. Terapi Profilaksis pada Tuberkulosis Laten

WHO menyarankan terapi profilaksis pada penderita tuberkulosis laten. Regimen yang direkomendasikan adalah:

- a. 6H atau 9H: isoniazid tiap hari selama 6 bulan atau 9 bulan

- b. 3HP: isoniazid dengan rifapentin tiap minggu selama 3 bulan
- c. 3HR: isoniazid dengan rifampisin tiap hari selama 3 bulan
- d. 4R: rifampisin tiap hari selama 4 bulan
- e. 1HP: isoniazid dengan rifapentin tiap hari selama 1 bulan
- f. H+B6+CPT: isoniazid, vitamin B6, dan kotrimoksazol tiap hari selama 6 bulan khusus untuk orang dengan HIV/AIDS.

Penatalaksanaan lainnya dapat dilakukan dengan memberikan perawatan yang tepat, antara lain:

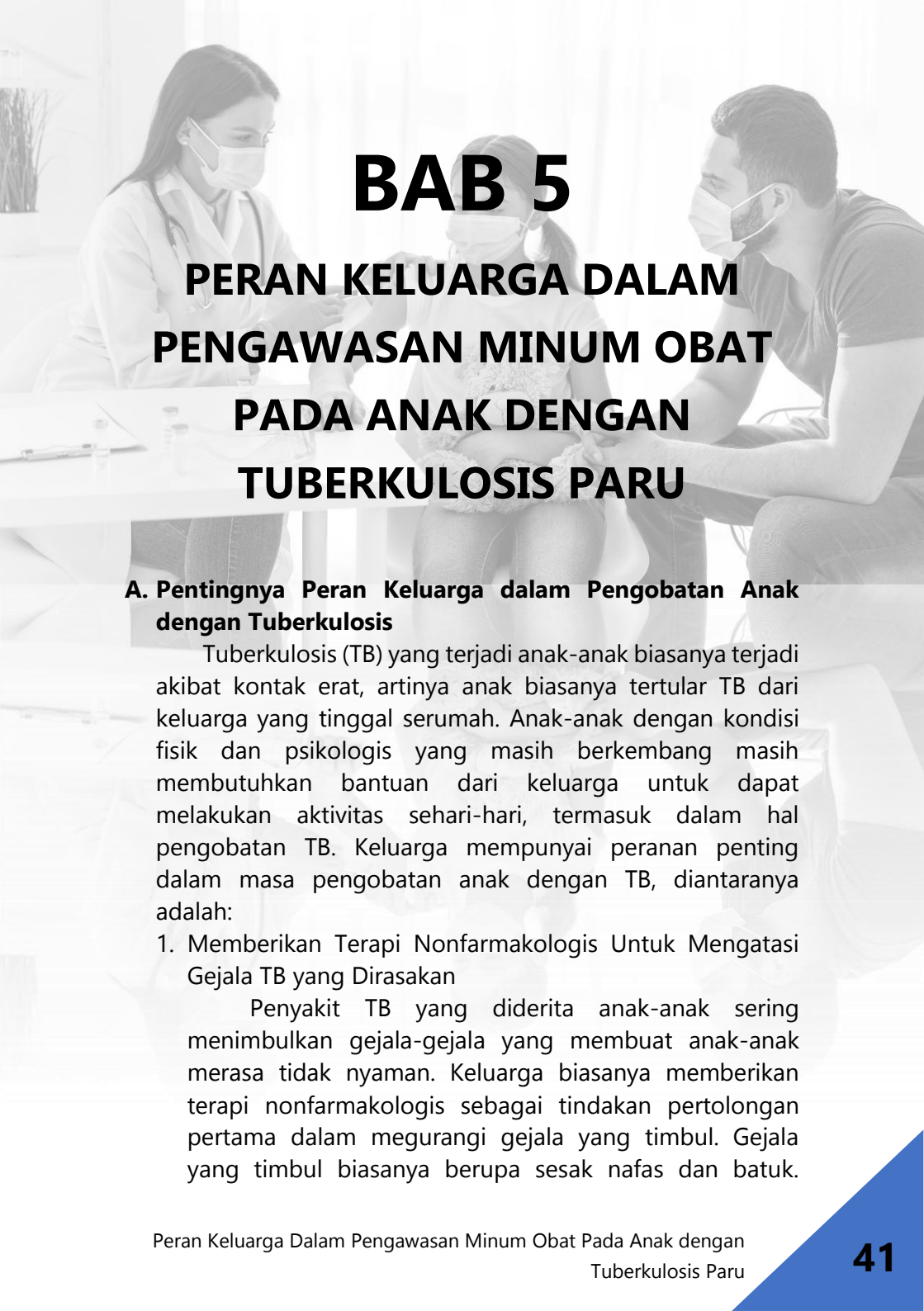
- 1. Apabila menemukan kasus Tb di masyarakat/ keluarga segera lapor ke pelayanan kesehatan.
- 2. Mendukung kepatuhan dan melakukan pengawasan pengobatan tuntas hingga 6 bulan
- 3. Edukasi penderita dan keluarga tentang menjaga pola hidup sehat, asupan gizi, lingkungan sehat, pola tidur dan istirahat yang cukup
- 4. Mencegah penularan ke anggota keluarga melalui kegiatan
 - a. Penggunaan masker dan hindari berbagi alat makan/minum
 - b. Mengajari penderita untuk menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku lengan
 - c. Memastikan penderita menggunakan masker, terutama saat berada di ruangan bersama orang lain
 - d. Membantu menjaga ventilasi rumah tetap baik agar udara segar bisa masuk
 - e. Memisahkan barang pribadi seperti alat makan dan handuk dari anggota keluarga lain

5. Memodifikasi lingkungan yang sehat bagi penderita Tb, melalui kegiatan:
 - a. Buka jendela dan pintu secara rutin agar terjadi sirkulasi udara silang (cross ventilation)
 - b. Ruang penderita sebaiknya terang dan mendapat sinar UV matahari langsung
 - c. Pemisahan ruang tidur penderita TB aktif dari anggota keluarga lain setelah 2–3 minggu terapi efektif
 - d. Jaga kebersihan ruangan yang sering dipakai dan hindari debu yang dapat membawa droplet
 - e. Penderita dianjurkan memakai masker saat berinteraksi dengan orang lain di dalam rumah
6. Dukungan sosial terhadap PMO dan program DOTS
 - a. Memberikan pendampingan bagi PMO
7. Mendampingi penderita TB paru dalam pemeriksaan rutin ke pelayanan kesehatan

I. REFERENSI

- Anggraini, D., & Kumala, O. (2022). Diare Pada Anak. *Scientific Journal*, 1(4), 309–317. <https://doi.org/10.56260/sciena.v1i4.60>
- Dianti, Y. (2023). Keperawatan keluarga. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Has, E. M. M., Ulfiana, E., Krisnana, I., Arief, Y. S., Mufidah, A., & Fathoni, M. (2020). Program Pagar Besi (Pendampingan Keluarga Sadar Dan Siaga Tuberkulosis Paru) Untuk Mencapai Zero Tb Case 2020 Di Wilayah Kerja Puskesmas Klampis Ngasem, Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

- Dalam Kesehatan*, 2(2), 36.
<https://doi.org/10.20473/jpmk.v2i2.20798>
- Kaakinen Jr and Birenbaum, RK (2017). Family Development and Family Nursing Assessment
<https://nursekey.com/family-development-and-family-nursing-assessment/>
- Kaakinen, J.R., Gedaly-Duff, V., Coehlo, D.P., & Hanson, S.M.H. (2013). Family Health Care Nursing : Theory, Practice And Research. Philadelphia : F.A. Davis Company.
- Kemendes RI (2019). Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta : Sekretarian Jenderal Kementerian Kesehatan.
- Kholifah, S.N & Widagdo, W. (2016). Keperawatan Keluarga dan Komunitas. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan. <http://bppsdmk.kemkes.go.id>.
- Mailani, F. (2023). *Tuberkulosis Konsep, Pencegahan, dan Perawatan*. 1–97.
- R, A. P., Erika, K. A., & Saleh, U. (2020). Pemberdayaan Keluarga dalam Perawatan Tuberkulosis. *Media Karya Kesehatan*, 3(1), 50–58.
<https://doi.org/10.24198/mkk.v3i1.24040>
- Setiawan, Ridwan. (2016). Teori & Praktek Keperawatan Keluarga. Semarang. UNNEs Press.
- Waworuntu, W., Pambudi, I., & Nurjannah. (2020). Strategi Komunikasi TOSS TBC. *TBC Indonesia*, 68.
<https://tbindonesia.or.id/pustaka/pedoman/umum/pedoman-strategi-komunikasi-toss-tbc-2022/>
- World Health Organization. (2021). Chronic Diseases and Prevention. Diakses dari www.who.int pada tanggal 10 Januari 2024.



BAB 5

PERAN KELUARGA DALAM PENGAWASAN MINUM OBAT PADA ANAK DENGAN TUBERKULOSIS PARU

A. Pentingnya Peran Keluarga dalam Pengobatan Anak dengan Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) yang terjadi anak-anak biasanya terjadi akibat kontak erat, artinya anak biasanya tertular TB dari keluarga yang tinggal serumah. Anak-anak dengan kondisi fisik dan psikologis yang masih berkembang masih membutuhkan bantuan dari keluarga untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal pengobatan TB. Keluarga mempunyai peranan penting dalam masa pengobatan anak dengan TB, diantaranya adalah:

- 1. Memberikan Terapi Nonfarmakologis Untuk Mengatasi Gejala TB yang Dirasakan**

Penyakit TB yang diderita anak-anak sering menimbulkan gejala-gejala yang membuat anak-anak merasa tidak nyaman. Keluarga biasanya memberikan terapi nonfarmakologis sebagai tindakan pertolongan pertama dalam mengurangi gejala yang timbul. Gejala yang timbul biasanya berupa sesak nafas dan batuk.

Keluarga biasanya melakukan tindakan nonfarmakologi seperti pemberian minyak kayu putih dan atomaterapi untuk melancarkan dan menghangatkan saluran nafas sehingga dapat mengurangi gejala yang muncul.

2. Melakukan Upaya Pemutusan Penularan

Upaya memutus rantai penularan TBC yang dimaksudkan merupakan tindakan yang dapat mencegah risiko penularan TBC. Pencegahan penularan TBC yang dapat dilakukan oleh keluarga biasanya sesuai dengan anjuran yang diberikan petugas kesehatan. Tindakan yang dilakukan oleh keluarga seperti menggunakan masker, tidak membuang dahak di sembarang tempat dan memisahkan peralatan makan dan minum penderita. Selain itu, usaha keluarga dalam mencegah penularan TBC dapat dengan memberikan pemahaman kepada penderita TBC. Memutus rantai penularan merupakan salah satu bentuk tugas dan peran keluarga. Salah satu tugas keluarga yaitu merawat anggota keluarga yang sakit dan mencegah penularan penyakit kepada anggota keluarga yang lain.

3. Dukungan Gizi

Keluarga mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien tuberkulosis. Pemberian gizi yang baik pada anak yang sakit akan membantu proses penyembuhan yang menderita tuberkulosis di rumah. Keluarga dapat memberikan gizi berupa protein dan buah-buahan selama proses pengobatan. Asupan protein yang cukup sangat penting bagi anak-anak penderita tuberkulosis (TB) karena dapat mendukung perbaikan jaringan, fungsi kekebalan tubuh, dan pemulihan secara menyeluruh. TB dapat merusak jaringan, dan protein membantu tubuh membangunnya kembali. Protein juga

memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang penting untuk melawan infeksi. Begitu juga dengan buah-buahan, bersama dengan pola makan yang seimbang, bermanfaat bagi anak-anak penderita TBC untuk mendukung pemulihan dan fungsi kekebalan tubuh mereka. Secara khusus, buah-buahan yang kaya akan vitamin A, C, dan E, seperti jeruk, mangga, dan beri, dapat menyediakan nutrisi penting. Vitamin-vitamin ini berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan melawan infeksi.

4. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental dapat diberikan kepada pasien Tb paru. Dukungan ini merupakan jenis dukungan sosial yang bersifat praktis dan nyata, dapat berupa bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat berupa bantuan fisik, layanan, atau sumber daya material yang membantu individu dalam menyelesaikan masalah. Dukungan yang dapat diberikan pada anak dengan TB antara lain mengingatkan anak yang sakit untuk minum obat dan menemani kontrol pendampingan ke pelayanan kesehatan.

5. Dukungan Emosional

Dukungan emosional berarti keluarga sebagai orang terdekat pasien memberikan motivasi kepada anak yang sakit selama proses pengobatan. Penderita tuberkulosis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalani pengobatan, sehingga anak memerlukan motivasi untuk meminimalisir respon negatif terhadap pengobatan.

Kepatuhan terhadap terapi lengkap sering kali menjadi tantangan, terutama karena perbaikan klinis dapat terjadi dengan cepat. Sebagian besar anak dengan TB akan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah 2-4 minggu

pengobatan anti-TB. Pada penilaian 2 bulan setelah dimulainya pengobatan, kemungkinan kegagalan pengobatan harus dipertimbangkan jika anak yang menerima pengobatan anti-TB:

1. Tidak mengalami perbaikan gejala atau gejalanya memburuk;
2. Menunjukkan penurunan berat badan yang terus-menerus;
3. Berhasil melakukan apusan dahak positif

Kepatuhan yang buruk merupakan penyebab umum dari “kegagalan pengobatan”. Kegagalan pengobatan menunjukkan kemungkinan TB-MDR dan memerlukan penilaian yang cermat. Untuk itu, orang tua dan keluarga sebagai orang terdekat anak dengan TB mempunyai peranan yang sangat penting dalam kepatuhan pengobatan.

1. Memberikan perhatian dan tidak mendeskriminasi

Ada berbagai bentuk perhatian yang dapat diberikan keluarga pada anak dengan TB, diantaranya yaitu menyadari ada sesuatu yang terjadi pada anak terkait dengan kesehatannya kemudian mencari tahu tentang hal itu dan mencari solusinya. Hal ini terlihat dari keluarga yang membawa anaknya berobat ke pelayanan kesehatan dan selalu aktif mencari informasi kesehatan untuk membantu kesembuhan anak. Selain itu, keluarga juga tidak boleh mendeskriminasi anak dengan TB seperti anak tetap dapat berkumpul dengan keluarga dengan menggunakan masker. Hal ini akan berdampak pada psikologis anak yang mempengaruhi proses penyembuhan.

2. Memberikan motivasi untuk menyelesaikan pengobatan

Pengobatan TB memerlukan waktu yang lama, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan terutama pada anak-anak. Keluarga dapat memberikan motivasi agar tidak bosan untuk minum obat dan tidak putus asa. Selain itu, efek samping obat yang dirasakan pada anak-anak dan jumlah obat yang diminum juga dapat membuat anak-anak enggan minum obat. Bentuk motivasi yang diberikan keluarga diantaranya meyakinkan anak tentang perubahan rasa sakit yang perlahan mulai berkurang dan memberi semangat kepada anak bahwa obat harus terus diminum secara teratur.

3. Mengusahakan agar OAT selalu tersedia di rumah

Anak dengan TB masih sangat tergantung kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan pengobatan. Keluarga mempunyai peran untuk mengusahakan agar OAT selalu tersedia di rumah. Keluarga bertugas untuk menjemput obat ke Puskesmas sebelum obat benar-benar habis untuk mencegah terjadinya kekosongan persediaan obat di rumah. Keluarga dapat menjemput obat sesuai dengan jadwal yang sudah disosialisasikan oleh petugas kesehatan di Puskesmas.

4. Sebagai Pengawas Minum Obat (PMO)

Keluarga dapat menjadi PMO dengan mengawasi anak minum obat secara teratur, memastikan anak tidak melewati dosis, dan mengingatkan anak untuk minum obat sesuai jadwal. PMO juga dapat memberikan motivasi kepada anak untuk tetap minum obat dan menjaga kesehatan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Keluarga dalam Pengawasan Minum Obat

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan minum obat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan kepatuhan yang lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan obat pada anak-anak penderita tuberkulosis mengungkapkan korelasi antara kepatuhan obat dan pendidikan orang tua. Anak-anak yang orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mematuhi terapi pengobatan dengan lebih tekun dibandingkan dengan mereka yang orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan orang tua yang berpendidikan tinggi memiliki banyak saluran informasi, pemahaman yang lebih baik tentang metode pemberian obat, dan informasi terkait penyakit lainnya, yang memungkinkan mereka untuk mengenali pentingnya penggunaan obat dalam jangka panjang. Akibatnya, pengawasan yang diberikan oleh orang tua tersebut memperkuat komitmen anak-anak terhadap rejimen pengobatan mereka.

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah pemahaman, persepsi, atau informasi tentang satu hal, seperti fakta, konsep, teori, atau keterampilan. Pengetahuan yang lebih baik tentang tuberkulosis dikaitkan secara positif dengan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap pengobatan antituberkulosis pada anak-anak. Penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa pemahaman yang kuat tentang obat antituberkulosis pada keluarga berdampak signifikan terhadap kepatuhan pengobatan TB pada anak-anak.

3. Status sosial ekonomi

TB pada anak-anak berdampak signifikan pada keuangan dan kesejahteraan keluarga. Beban ekonomi mencakup biaya langsung seperti pengobatan, transportasi, dan layanan kesehatan, serta biaya tidak langsung seperti hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak masuk kerja. Keluarga mungkin mengalami kesulitan keuangan, dengan beberapa melaporkan biaya yang sangat besar akan sibuk dalam pekerjaan di rumah dan mengurangi waktu dan konsentrasi dalam pengawasan minum obat.

C. Tantangan dalam Melibatkan Keluarga dalam Pengawasan Minum Obat

1. Kendala dan tantangan yang dihadapi keluarga dalam pengawasan minum obat.

Keluarga sering menghadapi kesulitan dalam mengawasi anak minum obat TB, terutama terkait kepatuhan, dukungan, dan pengetahuan.

a. Kepatuhan Minum Obat

Kepatuhan minum obat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu efek samping obat, durasi pengobatan, dan masalah sosio-ekonomi. Beberapa obat TB dapat menyebabkan efek samping yang tidak nyaman, sehingga anak mungkin enggan atau malas minum obat. Selain itu, durasi pengobatan yang Panjang berlangsung selama 6-9 bulan, bahkan lebih, yang bisa membuat anak dan keluarga merasa bosan atau putus asa. Masalah sosio-ekonomi juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas mungkin kesulitan mengakses layanan kesehatan, membeli obat, atau menyediakan kebutuhan anak selama pengobatan.

b. Dukungan Keluarga

Tantangan lain yang dimiliki keluarga dalam pengawasan minum obat adalah pengetahuan yang terbatas, kurangnya komunikasi, dan stigma serta diskriminasi.

Beberapa keluarga mungkin kurang memahami tentang TB, penyebabnya, cara penularan, dan pentingnya cara memberikan dukungan kepatuhan dalam pengobatan. Komunikasi yang buruk antara keluarga dan petugas kesehatan juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman tentang pengobatan. Selain itu, beberapa keluarga mungkin merasa malu atau takut untuk mengakui bahwa anak mereka terkena TB, sehingga mereka kurang aktif dalam mencari bantuan.

2. Stigma sosial dan tantangan dalam masyarakat yang perlu diatasi.

Adanya stigma sosial atau masyarakat merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keberhasilan pengobatan TB. Stigma adalah persepsi negatif pada seseorang yang menimbulkan jarak atau kesenjangan dari lingkungan sosialnya, menimbulkan perasaan malu dan terisolasi. Sumber lain menyebutkan bahwa stigma adalah atribut yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan oleh komunitas di mana atribut ini membedakan seseorang dari komunitasnya. dengan adanya atribut atau pandangan negatif ini seseorang akan "ditandai" dan dibedakan.

Stigma pada penderita TB dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang berakibat pada kesalahpahaman di masyarakat. Stigma pada TB dikaitkan dengan penyakit HIV, yang dianggap akibat perilaku tidak

bermoral, (dianggap) tidak bisa disembuhkan, dan mitos terkait penyebab TB. Stigma masyarakat yang muncul pada penderita TB dalam bentuk penghinaan, ejekan, diskriminasi, pengucilan sosial, dan isolasi sosial. Hasil penelitian di Cisarua Bogor menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat meyakini penyebab TB paru karena “guna-guna” karena mengira bahwa TB penyakit yang tidak bisa sembuh dan memiliki tanda gejala batuk berdarah. Selain itu juga terdapat stigma masyarakat yang dirasakan seperti menjaga jarak saat orang sakit TB mendekat, tidak mau untuk duduk berdekatan dengan orang yang sakit TB dan melarang anaknya untuk bermain dengan anak yang memiliki keluarga yang sakit TB.

Stigma sosial atau masyarakat sangat berdampak pada perilaku seseorang terhadap kesehatan. Stigma yang melekat pada TB dapat berkontribusi pada tertundanya pencarian kesehatan, kepatuhan pengobatan yang rendah, dan prognosis yang buruk. Selain itu, stigma juga dapat menurunkan kualitas hidup, status sosial dan kesulitan dalam kepatuhan pengobatan. Stigma juga mempunyai dampak negative pada anak dengan TB. Stigma yang tidak teratasi akan menurunkan kemampuan anak dalam memenuhi tumbuh kembangnya, terutama aspek sosial karena anak tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungan yang menolak dirinya. Anak penderita TB sering kali menghadapi rasa gelisah dan pengertian dalam lingkungan sosial. Stigma TB yang dapat berdampak pada anak antara lain rendahnya harga diri, diskriminasi, pengucilan sosial, dan isolasi yang dapat menurunkan status sosial, menurunkan kualitas hidup, dan kesulitan dalam kepatuhan pengobatan.

D. Strategi Penguatan Peran Keluarga

Anak-anak, orang tua mereka, anggota keluarga lainnya, dan pengasuh lainnya harus diberi edukasi tentang TB dan pentingnya menyelesaikan pengobatan. Dukungan dari orang tua dan keluarga dekat anak sangat penting untuk memastikan hasil pengobatan yang memuaskan. Selain itu, dukungan sosial dan masyarakat juga penting untuk keberhasilan pengobatan TB pada anak.

1. Pelatihan dan edukasi kesehatan bagi keluarga untuk memperkuat pengawasan minum obat.

Pelatihan adalah proses belajar dan praktik yang terencana untuk mengubah sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan seseorang atau kelompok orang. Sedangkan edukasi kesehatan merupakan kegiatan pengembangan, pemberian instruksi dan pengalaman belajar untuk memfasilitasi individu, keluarga maupun masyarakat untuk secara sukarela beradaptasi dengan perilaku kesehatan yang kodusif.

Pelatihan dan edukasi kesehatan tentang penyakit TB paru, mengenali gejala penyakit TB sejak dini, memahami pentingnya penemuan kasus TB, pengobatan dan juga pencegahan TB paru, memberikan edukasi terkait dampak jika tidak minum obat dengan teratur dan efek yang ditimbulkan pada pasien yang minum obat TB tidak teratur. Selain itu dalam mendampingi dan melakukan edukasi, keluarga juga perlu dilatih kemampuan dasar cara berkomunikasi dan negosiasi yang baik sehingga bisa meyakinkan anak dengan TB untuk melakukan pengobatan yang benar dan upaya pencegahan penularan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sebagai PMO yang mempunyai pengetahuan baik akan lebih baik dalam pendampingan

pasien TB paru. Informasi yang diperoleh melalui pelatihan berdampak pada meningkatnya pengetahuan pengawas menelan obat tentang tata laksana pengobatan dan pendampingan TB paru.

Hasil pelatihan yang diikuti keluarga/PMO menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan peserta menjadi terampil, tanggap dan cekatan dalam menentukan tindakan yang diambil saat menjumpai pasien yang menderita suspek TB paru.

2. Dukungan sosial dan komunitas dalam membantu keluarga.

Dukungan sosial dan komunitas berperan penting dalam membantu anak-anak penderita tuberkulosis (TB) mematuhi rencana pengobatan mereka, yang dapat meningkatkan hasil pengobatan secara signifikan dan mengurangi risiko berkembangnya TB yang resistan terhadap obat. Jaringan dukungan sosial yang kuat, yang meliputi keluarga, teman, dan anggota komunitas, dapat memberikan dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan, yang semuanya berkontribusi pada kepatuhan pengobatan.

Berikut ini adalah manfaat dukungan sosial dan komunitas bagi anak-anak penderita TB:

3. Dukungan Emosional

Keluarga dan teman-teman dapat menciptakan lingkungan yang mendukung yang membantu anak-anak merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama perawatan, sehingga mengurangi stres dan kecemasan. Dukungan dari orang-orang terkasih dapat mendorong anak-anak untuk minum obat sesuai resep, menumbuhkan rasa harapan dan optimisme tentang pemulihan mereka.

4. Dukungan Instrumental

Anggota keluarga atau komunitas dapat membantu pemberian obat, memastikan anak-anak minum pil pada waktu yang tepat dan dalam dosis yang tepat. Dukungan juga dapat mencakup penyediaan transportasi ke fasilitas kesehatan, memastikan akses ke sumber daya yang diperlukan, dan mengatasi tantangan logistik lainnya.

5. Dukungan Informasional

Anggota keluarga dan komunitas dapat mendidik anak-anak dan pengasuh mereka tentang TB, pengobatannya, dan pentingnya kepatuhan. Mereka dapat membantu menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran tentang pengobatan, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepatuhan.

6. Dukungan Apresiasi

Mengakui dan memuji anak-anak karena minum obat dapat memperkuat perilaku positif dan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. Mengetahui bahwa mereka dihargai dan didukung oleh keluarga dan komunitas dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka untuk mengikuti rencana pengobatan.

7. Peran Komunitas

Petugas kesehatan komunitas atau relawan dapat memberikan pengingat, kunjungan rumah, dan dukungan secara berkala, memastikan bahwa anak-anak menerima dorongan dan bimbingan yang konsisten. Menghubungkan anak-anak dengan individu lain yang pernah mengalami TB atau sedang menjalani pengobatan dapat memberikan dukungan emosional yang berharga dan pengalaman bersama. Program berbasis komunitas dapat menyediakan dukungan gizi, konseling, dan jaringan dukungan sosial untuk membantu anak-anak mengatasi TB dan pengobatannya.

Sebagai kesimpulan, dukungan sosial dan komunitas merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pada anak-anak penderita TB, yang mengarah pada hasil yang lebih baik dan mengurangi risiko mengembangkan resistensi obat.

E. REFERENSI

- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2016). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. In *Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health* (pp. 413–414).
- Shoghi, M., Shahbazi, B., & Seyedfatemi, N. (2019). The effect of the Family-Centered Empowerment Model (FCEM) on the care burden of the parents of children diagnosed with cancer. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 20(6), 1757–1764. <https://doi.org/10.31557/APJCP.2019.20.6.1757>
- Graves, K. N., & Shelton, T. L. (2017). Family empowerment as a mediator between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change. *Journal of Child and Family Studies*, 16(4), 556–566. <https://doi.org/10.1007/s10826-006-9106-1>
- Muhammad, S. D., Wijaya., Max. F. J., Mantik., Novie. H., Rampengan. (2021). *Faktor Risiko Tuberkulosis*

pada Anak. *Journal e-CliniC*. 9(1):124-133. DOI: <https://doi.org/10.35790/eci.9.1.2021.32117>

- Sanaie, N., Nejati, S., Zolfaghari, M., Alhani, F., & Kazemnezhad, A. (2019). The Effects of Family-based Empowerment on Family Cooperation in Following Patient Treatment Regime after Coroner Arteries Bypass Surgery. *Modern Care Journal*, 11, 19–27.
- Erlinda, V., & Kunci, K. (2015). Application Of Family-Centered Nursing Model On The Execution Of Family Health Care In Preventing Acute Respiratory Tract Infection Of Under 5 Years Children In The Working Area Of Simpang Tiga Public Health Center Aceh. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 23(2), 165–186.
- Kashaninia, Z., Payroovee, Z., Soltani, R., & Mahdaviani, S. A. (2018). Effect of Family Empowerment on Asthma Control in. *Tanaffos*, 17(1), 47–52.
- Moattari, M., Ebrahimi, M., Sharifi, N., & Rouzbeh, J. (2012). The effect of empowerment on the self-efficacy, quality of life and clinical and laboratory indicators of patients treated with hemodialysis: A randomized controlled trial. *Health and Quality of Life Outcomes*, 10, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-10-115>
- Wacharasin, C., Phaktoop, M., & Sananreangsak, S. (2015). A family empowerment program for families having children with thalassemia,

Thailand. Nursing and Health Science, 17(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nhs.12201>

Anderson, E. T., & Mcfarlane, J. (2016). Community As Patner Theory and Practice in Nursing (7th ed.). Wolter Kluwer, Lippincott Wiliams & Wilkins

Friedman, L. M. (2015). Buku ajar keperawatan keluarga: riset, teori, praktik (5thed). Jakarta: EGC

Sovia dkk. (2023). Bunga Rampai Keperawatan Keluarga. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.

Puspasari, Maria Elena. (2017). Pembentukan Ruang Virtual Medai Interaktif dalam Proses Edukasi. Jurnal Kreativitas. 3(2):347-357.

Wenno, S.Z., Kolompoy dkk. (2023). Keperawatan komunitas dan kesehatan masyarakat Jilid 1. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.

Nurhaliza. W.O.S dan Fauziah. N. (2020). Komunikasi Kelompok dalam Virtual Community. Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah. 10(01); 18-38; DOI:10.35905/komunida.v7i2. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/index>

Sovia dkk. (2023). Bunga Rampai Keperawatan Keluarga. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.

Kurniawan. W dan Agustini. A. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan dan Keperawatan. Cimahi Jawa Barat Indonesia: CV Rumah Pustaka

Alhani F, Asghari-Jafarabadi M, Norouzadeh R, Rahimi-Bashar F, Vahedian-Azimi A, Jamialahmadi T, Sahebkar A. The effect of family-centered empowerment model on the quality of life of adults with chronic diseases: An updated systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord.* 2022 Nov 1;316:140-147. doi: 10.1016/j.jad.2022.07.066. Epub 2022 Aug 11. PMID: 35964767

Febriyanti, C.E., & Setiyadi, N.A. (2023). Differences in the Effectiveness of Audiovisual Media and Leaflets on the Knowledge and Attitudes of Mothers of Toddlers in Bogorejo Village About Stunting. *Gaster*.



BAB 6

IMPLEMENTASI FAMILY CENTERED EMPOWERMENT MODEL (FCEM) DALAM PENGAWASAN MINUM OBAT

A. Pemberdayaan peran keluarga dalam Pengawasan Minum Obat

Dalam praktik pelayanan kesehatan, kepatuhan minum obat menjadi salah satu tantangan utama, khususnya pada pasien anak. Anak-anak belum memiliki kapasitas untuk secara mandiri memahami pentingnya terapi farmakologis dan sering kali bergantung sepenuhnya pada dukungan keluarga, terutama orang tua. Oleh karena itu, model pemberdayaan keluarga menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan minum obat, sekaligus mendukung keberhasilan terapi secara keseluruhan.

Pemberdayaan dalam pengawasan pengobatan anak Tb paru adalah sebagai pengawas minum obat (PMO). Pengawasan minum obat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab utama keluarga dalam konteks perawatan anak. Dalam banyak kasus, kepatuhan minum obat yang buruk bukan hanya disebabkan oleh kelalaian, tetapi karena kurangnya pemahaman keluarga terhadap jadwal pemberian

obat yang benar, efek samping obat yang mungkin terjadi. Serta pentingnya menyelesaikan seluruh dosis sesuai anjuran dokter, terutama untuk penyakit kronis atau infeksi.

Pemberdayaan keluarga membantu mengatasi hambatan-hambatan ini melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Perawat dapat melakukan edukasi dengan pendekatan yang terstruktur, misalnya melalui kegiatan pemberdayaan keluarga dalam pelatihan tentang teknik pemberian obat yang tepat, penggunaan alat bantu visual seperti grafik jadwal minum obat, serta pengingat elektronik (aplikasi atau alarm) yang mudah digunakan oleh keluarga.

B. Langkah-langkah pemberdayaan peran keluarga dalam Pengawasan Minum Obat

Keluarga perlu memahami tugas perawatan kesehatan yang dapat dilaksanakan secara mandiri. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pemberdayaan keluarga untuk pengawasan obat:

1. Edukasi individu dan keluarga: penjelasan tentang penyakit anak, mekanisme kerja obat, serta konsekuensi jika pengobatan tidak dijalankan dengan benar.
2. Identifikasi hambatan: mencari tahu apa yang membuat keluarga kesulitan menjalankan pengobatan, seperti masalah ekonomi, ketidaktahuan, atau stigma.
3. Peningkatan keterampilan: mengajarkan keterampilan teknis seperti pemberian obat cair, penggunaan inhaler, atau penyesuaian dosis sesuai usia/berat badan.
4. Pemantauan dan evaluasi berkala: memberikan ruang bagi keluarga untuk menyampaikan laporan berkala dan mendapat umpan balik dari tenaga medis.

Dengan pemberdayaan ini, keluarga tidak hanya menjadi pelaksana perintah medis, tetapi juga mitra aktif yang terlibat dalam pencapaian hasil kesehatan anak.

Peran keluarga dalam mendukung terapi dan pengobatan sangatlah penting. Dalam konteks model pemberdayaan, peran keluarga menjadi jauh lebih luas daripada hanya sekadar "memberi obat". Berikut adalah beberapa peran penting keluarga yang diperkuat melalui pendekatan *Family Centered Empowerment Model (FCEM)*:

1. Sebagai motivator

Anak-anak sangat bergantung pada dukungan emosional dari orang tuanya. Keluarga berperan penting dalam memberikan motivasi kepada anak agar tidak takut dengan proses pengobatan dan memahami bahwa minum obat adalah bagian dari proses penyembuhan. Orang tua yang tenang, sabar, dan mendampingi anak dengan kasih sayang saat minum obat dapat mengurangi kecemasan anak dan meningkatkan kerja sama.

a. Sebagai pengamat dan pelapor

Keluarga harus dilibatkan dalam pemantauan respons anak terhadap obat. Hal ini mencakup pengamatan terhadap:

- 1) Efek terapeutik (apakah kondisi membaik atau memburuk),
- 2) Efek samping (ruam, muntah, diare, gangguan tidur, gangguan eliminasi),
- 3) Perubahan perilaku anak setelah minum obat.

Informasi perubahan perilaku ini penting disampaikan kembali ke tenaga kesehatan sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian pengobatan.

b. Sebagai komunikator

Dalam praktiknya, banyak keluarga yang tidak menyampaikan informasi penting selama proses konsultasi. Dalam model pemberdayaan, keluarga dibimbing untuk lebih terbuka dan aktif menyampaikan kebutuhan, kesulitan, dan harapan mereka selama perawatan berlangsung. Peran ini memungkinkan tenaga medis membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai konteks.

c. Sebagai pendengar yang aktif. Lingkungan rumah yang mendukung dari pola makan sehat, waktu istirahat yang cukup, hingga manajemen stres anak mempercepat pemulihan. Keluarga perlu memahami bahwa aspek psikososial juga turut memengaruhi efektivitas terapi.

d. Sebagai pengambil keputusan bersama (*Shared Decision Making*)

Keluarga harus dilibatkan dalam memilih jenis pengobatan, metode pemberian obat, dan jadwal yang paling sesuai dengan rutinitas anak. Pemberian ruang untuk memilih meningkatkan rasa tanggung jawab keluarga dalam menjalankan pengobatan secara konsisten.

C. Tahapan implementasi Model FCEM

Implementasi model FCEM membutuhkan kegiatan seperti berikut:

1. Tahap persiapan model

- a. Persiapan dan pengenalan model kepada keluarga dan tenaga kesehatan
- b. Pembentukan tim pengawasan di tingkat keluarga.
- c. Orientasi dan sosialisasi program ke rumah sakit, puskesmas, dan komunitas.

2. Tahap pelaksanaan
 - a. Metode pelatihan keluarga untuk mengawasi minum obat.
 - b. Penggunaan teknologi untuk memantau pengawasan obat (misalnya aplikasi, reminder).
3. Evaluasi dan monitoring
 - a. Cara mengevaluasi efektivitas implementasi model.
 - b. Indikator keberhasilan dan pengukuran dampak terhadap pengawasan minum obat.
4. Rencana tindak lanjut
 - a. Identifikasi hambatan yang mungkin muncul selama implementasi
 - b. Solusi dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut

D. REFERENSI

- Nies, M., & Mc Ewen, M. (2018). Community Public Health Nursing: Promoting The Health of Population (7 th). Elsevier Inc.
- Kemenkes RI. (2022). Tuberculosis prevention and control comunitable diseases. Badan Pencegahan Pengendalian Penyakit: Jakarta
- Kemenkes RI. (2023). Program penanggulangan tuberkulosis. Badan Pencegahan Pengendalian Penyakit: Jakarta
- Patriani A, Paramastri I, Priyanto M. (2017). Pemberdayaan Keluarga Dalam Rehabilitasi Medik Paru Pada Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik di Balai Pengobatan Penyakit Paru Yogyakarta.
- Isbaniah, F., Burhan. E, Sinaga. B.Y.M., Yanifitri. B.H, Handayani. D., dkk. (2021). Panduan dan diagnosis

- penatalaksanaan Tuberkulosis di Indonesia. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI): Jakarta.
- Ibrahim, G.A., Ismadi. H.D., Zabadi. F., Ali. N.B.V., Alipi. M., Antoro. B., Hanifah. N., Miftahussurari, Nento. M.N., Akbari. Q.S & Aziz. M. (2017). Peta Jalan gerakan literasi nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sovia dkk. (2023). Bunga Rampai Keperawatan Keluarga. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.
- Puspasari, Maria Elena. (2017). Pembentukan Ruang Virtual Medai Interaktif dalam Proses Edukasi. Jurnal Kreativitas. 3(2):347-357.
- Wenno, S.Z., Kolompoy dkk. (2023). Keperawatan komunitas dan kesehatan masyarakat Jilid 1. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.
- Nurhaliza. W.O.S dan Fauziah. N. (2020). Komunikasi Kelompok dalam Virtual Community. Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah. 10(01); 18-38; DOI:10.35905/komunida.v7i2.
<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/komunida/index>
- Sovia dkk. (2023). Bunga Rampai Keperawatan Keluarga. Banyumas: PT Pena Persada Kerta Utama.
- Kurniawan. W dan Agustini. A. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan dan Keperawatan. Cimahi Jawa Barat Indonesia: CV Rumah Pustaka
- Ihani F, Asghari-Jafarabadi M, Norouzadeh R, Rahimi-Bashar F, Vahedian-Azimi A, Jamialahmadi T, Sahebkar A. The effect of family-centered empowerment model

on the quality of life of adults with chronic diseases: An updated systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord.* 2022 Nov 1;316:140-147. doi: 10.1016/j.jad.2022.07.066. Epub 2022 Aug 11. PMID: 35964767

Febriyanti, C.E., & Setiyadi, N.A. (2023). Differences in the Effectiveness of Audiovisual Media and Leaflets on the Knowledge and Attitudes of Mothers of Toddlers in Bogorejo Village About Stunting. *Gaster*.



BAB 7

PENDEKATAN BERBASIS KELUARGA DALAM MANAJEMEN TUBERKULOSIS PADA ANAK

A. Pendahuluan

Bagian terkecil dari masyarakat yang terbentuk selama proses perkembangan kehidupan manusia disebut dengan keluarga. Setiap manusia akan tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Keluarga merupakan salah satu aspek yang penting dalam upaya Kesehatan. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam menjaga Kesehatan anggota keluarganya (Mursida dkk, 2022).

Perawat adalah salah satu profesi kesehatan yang mampu mengoptimalkan peran keluarga dalam menyediakan sumber-sumber yang penting untuk memberikan pelayanan Kesehatan/ keperawatan bagi individu sendiri dan orang lain dalam keperawatan. Perawat melihat keluarga sebagai objek dan subjek perawatan sehingga secara menyeluruh setiap individu yang ada dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan secara langsung menjadi klien dalam keperawatan keluarga dalam implementasi berbagai upaya Kesehatan keluarga yang sehat

maupun sakit untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga.

B. Konsep Dasar Keluarga

1. Defenisi

Ada beberapa pengertian keluarga dari beberapa ahli. Keluarga adalah orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan emosional dan setiap individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga (Friedman, Bowden dan Jones, 2003). Keluarga adalah suatu lembaga unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari ayah, ibu dan anak (Kemenkes, 2016). Sedangkan Kaakinen, JR, et al, (2018) Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergantung satu sama lain dan saling memberikan dukungan emotional, fisik dan ekonomi, dimana anggota dari keluarga dapat ditentukan sendiri oleh keluarga. Sehingga keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih karena adanya ikatan perkawinan hubungan darah, adopsi yang hidup Bersama dan saling berinteraksi, untuk mencapai kesejahteraan.

2. Tipe-Tipe Keluarga

Keluarga dibagi menjadi dua tipe keluarga antara lain keluarga tradisional dan nontradisional (Kholifah dan widagdo, 2016: Blakeley, 2021). Tipe keluarga tradisional antara lain:

a. Keluarga Inti (The Nuclear family)

keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu yang tinggal bersama untuk membesarkan anak-anaknya. Anak yang ada di keluarga merupakan keturunannya atau diadopsi ataupun keduanya.

- b. Keluarga besar (*Extended family*)
keluarga yang terdiri atas keluarga inti ditambah keluarga lain, seperti paman, bibi, kakek, nenek, dan sebagainya yang memiliki hubungan darah. Tipe keluarga ini masih banyak dianut oleh keluarga Indonesia.
 - c. Keluarga dyad (*The dyad family*),
suatu rumah tangga yang terdiri atas suami dan istri tanpa anak. Hal yang perlu diketahui, keluarga ini mungkin belum mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.
 3. *Single Parent*
Keluarga yang terdiri atas satu orang tua dengan anak (andung atau angkat). Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian.
 4. *Single adult*,
Suatu rumah tangga yang terdiri atas satu orang dewasa. Tipe ini dapat terjadi pada seorang dewasa yang tidak menikah atau tidak mempunyai suami.
 5. *Middle-aged or elderly couple*,
Orang tua yang tinggal sendiri di rumah (baik suami/istri atau keduanya), karena anak-anaknya sudah membangun karir sendiri atau sudah menikah.
 6. *Kin-network family*,
Beberapa keluarga yang tinggal bersama atau saling berdekatan dan menggunakan barang-barang pelayanan, seperti dapur dan kamar mandi yang sama.
Sedangkan kategori keluarga berdasarkan tipe keluarga non-tradisional antara lain:
 1. *Unmarried parent and child family*, yaitu keluarga yang terdiri atas orang tua dan anak dari Bungan tanpa menikah.

2. *Cohabiting couple*, orang tua yang hidup Bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu.
3. *Gay and lesbian family*, seseorang yang mempunyai persamaan jenis kelamin tinggal dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri.
4. *The nonmarital heteroseksual cohabiting family*, keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan.
5. *Foster family*, diaman keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga/ saudara dalam waktu sementara, pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan Kembali keluarga yang aslinya.

C. Fungsi-Fungsi di Keluarga

Pada keluarga terdapat berbagai fungsi untuk kesinambungan perkembangan siklus keluarga. Kaakinen JR and Birenbaum RK (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan tentang fungsi dan struktur keluarga sangat penting untuk memahami bagaimana keluarga memengaruhi kesehatan, penyakit, dan kesejahteraan. Perawat yang memahami fungsi dan struktur keluarga dapat menggunakan pengetahuan ini untuk memberdayakan keluarga melalui intervensi berbasis bukti.

Fungsi keluarga adalah cara keluarga memenuhi kebutuhannya baik untuk setiap anggota keluarga, keluarga secara keseluruhan, dan hubungannya dengan masyarakat. Fungsi keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengkoordinasikan dan mengadaptasi perubahan sepanjang hidup, menyelesaikan konflik, bekerja sama antar anggota dan sukses dalam pola disiplin, menghormati batas-batas antar individu dan menghormati peraturan dan prinsip

yang membantu keluarga untuk melindungi keluarga dan seluruh sistem keluarga.

Fungsi keluarga dipengaruhi oleh pola asuh/pengasuhan yang ada di keluarga. Fungsi keluarga akan berperan dengan keragaman yang luar biasa untuk mengatasi stressor yang sifatnya dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi serta perubahannya di keluarga. Keluarga berfungsi dengan baik jika saling memberikan kebebasan, motivasi, serta perlindungan dan keamanan untuk mencapai potensi diri bagi anggota keluarga.

Fungsi pokok keluarga berdasarkan Friedman & Bowden (2010) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi Afektif

Merupakan fungsi utama dalam mengajarkan keluarga segala sesuatu dalam mempersiapkan anggota keluarga dapat bersosialisasi dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga

2. Fungsi Sosialisasi merupakan proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi Reproduksi merupakan fungsi untuk mempertahankan keturunan atau generasi dan dapat menjaga kelangsungan keluarga.
4. Fungsi Ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu sehingga

meningkatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan. Pendapatan keluarga adalah bagian penting dari ekonomi keluarga, tetapi juga terkait dengan konsumerisme keluarga, pengelolaan uang, keputusan perumahan, pilihan asuransi, pensiun, dan tabungan. Ekonomi keluarga memengaruhi dan mencerminkan ekonomi bangsa

5. Fungsi perawatan merupakan fungsi dalam mempertahankan status kesehatan keluarga dan anggota keluarga agar tetap produktif. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.

D. Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan

Tugas pemeliharaan kesehatan dikenal dengan 5M antara lain; Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya, Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat, Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya, Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. Dalam keluarga seseorang akan belajar konsep kesehatan, promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan manajemen penyakit di keluarga. Anggota keluarga memberikan pengasuhan informal kepada anggota keluarga yang sakit dan merupakan sumber dukungan utama.

Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan ini menjadi penting. Tugas perawatan kesehatan keluarga memberi peluang 12 kali dalam meningkatkan status kesehatan pada agregat masyarakat menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak melakukan tugas perawatan kesehatan keluarga dengan baik. Kurangnya

pengetahuan keluarga khususnya mengenai tugas kesehatan keluarga dapat berakibat tidak tepatnya penanganan yang diberikan kepada anggota keluarga yang sakit..

E. Pentingnya pemberdayaan keluarga dalam pengelolaan tuberkulosis anak.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki peranan penting. Tugas kesehatan keluarga jika dijalankan dengan baik maka akan meningkatkan 12 kali peluang untuk meningkatkan status kesehatan keluarganya daripada keluarga yang abai terhadap tugas pemeliharaan Kesehatan. Jika keluarga tidak melakukan tugas perawatannya dengan baik terutama pada anggota keluarga yang menderita TB maka memperlama waktu rawat dan memiliki prognosis penyakit yang semakin memburuk.

F. Penerapan Tugas Perawatan Kesehatan Keluarga Pada Masalah Tuberkulosis

Sebelum penerapan tugas perawatan kesehatan keluarga pada masalah tuberculosi, maka seorang perawat dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada keluarga tentang tugas pemeliharaan kesehatan anggota keluarganya sebagai berikut:

1. Adakah anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan atau sakit saat ini?

☐ Ada ☐ Tidak

Karena.....

2. Apakah ada anggota keluarga yang pernah terkena masalah kesehatan yang sama dengan klien sebelumnya?

☐ Ada ☐ Tidak

Karena.....

3. Siapa yang membantu jika ada anggota keluarga yang menderita sakit?

☐ Semua anggota ☐ hanya ibu/ayah

Lainnya.....

4. Adakah perhatian keluarga kepada anggota keluarga yang sakit?

☐ Ada. ☐ Tidak ada,

sebab.....

5. Apakah keluarga mengetahui masalah Kesehatan yang dialami klien?

☐ Ada ☐ Tidak,

sebab.....

6. Apakah keluarga mengetahui penyebab masalah Kesehatan yang dialami klien?

☐ Ya. ☐ Tidak,

sebab.....

7. Apakah keluarga mengetahui tanda dan gejala masalah Kesehatan yang dialami klien?

☐ Ada. ☒ Tidak

karena.....

8. Apakah keluarga mengetahui akibat masalah Kesehatan yang dialami pasien bilak tidak diobati/ dirawat?

☐ Ada ☐ Tidak

.....

9. Pada siapa keluarga biasa menggali informasi tentang maslaah Kesehatan keluarganya

.....

10. Keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan tersebut: tidak perlu ditangani karena akan sembuh sendrii biasanya perlu berobat ke fasilitas yankes,,,,,,, tidak terpikir sebab,,,,,,,,

11. Apakah keluarga melakukan upaya peningkatan Kesehatan anggota secara aktif

☐ Ya. ☐ Tidak,

jelaskan.....

12. Apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah Kesehatan yang dialami pasien?

☐ Ya. ☐ Tidak

13. Apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah Kesehatan yang dialami pasien?

☐ Ya. ☐ Tidak

.....

14. Apakah keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga dengan masalah Kesehatan yang dialami pasien?

☐ Ada. ☐ Tidak

.....

15. Apakah keluarga dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan yang dialami pasien

☐ Ada ☐ Tidak

16. Apakah keluarga mampu memelihara atau memodifikasi lingkungan yang mendukung Kesehatan anggota keluarga yang mengalami masalah Kesehatan?

☐ Ada. ☐ Tidak

.....

17. Apakah keluarga mampu menggali dan memanfaatkan sumber masyarakat untuk mengatasi masalah Kesehatan pada anggota keluarganya?

☐ Ada. ☐ Tidak

Setelah dilakukan pengkajian didapatkan masalah kesehatan keluarga maka pemberdayaan keluarga dapat dilakukan dengan masalah tuberkulosis. Beberapa data masalah keperawatan yang mungkin muncul untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga:

1. Penurunan keterampilan dalam memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar: oksigenisasi anggota keluarga yang sakit.
3. Perilaku kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan
4. Perilaku kurang dalam mencari bantuan Kesehatan
5. Perilaku kurang dalam melakukan upaya pencegahan penularan TBC pada anggota keluarga yang lain.
6. Kurang menunjukkan minat pada perbaikan perilaku sehat

7. Ketidalcukupan sumber daya (tenag, sarana dan keuangan).
8. Kurang kemampuan dalam komunikasi
9. Tugas perkembangan tidak tercapai

Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada keluarga dengan tuberkulosis adalah ketidakefektifa pemeliharaan Kesehatan. Maka pemberdayaan keluarga dapat dimulai dari fungsi pemeliharaan kesehatan antara lain:

1. Keluarga mampu mengenal masalah tuberkulosis
2. Keluarga mendapatkan Pendidikan Kesehatan tentang proses penyakit tuberkulosis dan manajemen penyakit tuberkulosis.
3. Keluarga mampu mengambil keputusan untuk melakukan perawatan kesehatan atau memperbaiki keadaan masalah tuberkulosis
4. Keluarga berpartisipasi dalam memutuskan perawatan Kesehatan Dimana keluarga mengrestrukturisasi kognitif, dukungan membuat Keputusan dan membangun harapan sehat.
5. Keluarga mampu melakukan perawatan kesehatan keluarga yang sakit untuk meningkatkan dan memperbaiki kesehatan akibat masalah tuberkulosis.
6. Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami tuberkulosis dengan cara melakukan manajemen jalan nafas, fisioterapi dada, Latihan batuk, terapi oksigenasi, monitoring pernafasa, terapi relaksasi, dan manajemen pengobatan.
7. Keluarga mampu memodifikasi lingkungan, kontrol infeksi dan keamanan pada masalah tuberkulosis
8. Memodifikasi lingkuang untuk keluarga dengan tuberkulosis dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi

- factor resiko, pencegahan infeksi serta manajemen lingkungan kamanan
9. Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan pada masalah tuberculosis.
 10. Tahap terakhir dalam merawat anggota keluarga tuberculosis adalah memanfaatkan fasilitas Kesehatan dengan cara konsultasi tentang penyakit tuberculosis, rujukan dan panduan istem Kesehatan sehingga keluarga merasa puas terhadap pelayanan dan bantuan dari fasilitas Kesehatan.

G. REFERENSI

- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2021). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2021.<http://www.kemkes.go.id>.
- Kemenkes RI. (2020). Kondisi penyakit tidak menular di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Allender, J. A., Rector, C., & Warner, K. D. (2016). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. In Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health (pp. 413–414).
- Shoghi, M., Shahbazi, B., & Seyedfatemi, N. (2019). The effect of the Family-Centered Empowerment Model (FCEM) on the care burden of the parents of children diagnosed with cancer. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 20(6), 1757–1764. <https://doi.org/10.31557/APJCP.2019.20.6.1757>

- Graves, K. N., & Shelton, T. L. (2017). Family empowerment as a mediator between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change. *Journal of Child and Family Studies*, 16(4), 556–566. <https://doi.org/10.1007/s10826-006-9106-1>
- Muhammad, S. D., Wijaya., Max. F. J., Mantik., Novie. H., Rampengan. (2021). Faktor Risiko Tuberkulosis pada Anak. *Journal e-CliniC*. 9(1):124-133. DOI: <https://doi.org/10.35790/eci.9.1.2021.32117>
- Sanaie, N., Nejati, S., Zolfaghari, M., Alhani, F., & Kazemnezhad, A. (2019). The Effects of Family-based Empowerment on Family Cooperation in Following Patient Treatment Regime after Coroner Arteries Bypass Surgery. *Modern Care Journal*, 11, 19–27.
- Erlinda, V., & Kunci, K. (2015). Application Of Family-Centered Nursing Model On The Execution Of Family Health Care In Preventing Acute Respiratory Tract Infection Of Under 5 Years Children In The Working Area Of Simpang Tiga Public Health Center Aceh. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 23(2), 165–186.
- Kashaninia, Z., Payroovee, Z., Soltani, R., & Mahdaviani, S. A. (2018). Effect of Family Empowerment on Asthma Control in. *Tanaffos*, 17(1), 47–52.
- Moattari, M., Ebrahimi, M., Sharifi, N., & Rouzbeh, J. (2012). The effect of empowerment on the self-efficacy, quality of life and clinical and laboratory indicators of patients treated with hemodialysis: A randomized controlled trial. *Health and Quality of Life*

Outcomes, 10, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-10-115>

Wacharasin, C., Phaktoop, M., & Sananreangsak, S. (2015). A family empowerment program for families having children with thalassemia, Thailand. *Nursing and Health Science*, 17(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nhs.12201>

Anderson, E. T., & Mcfarlane, J. (2016). *Community As Patner Theory and Practice in Nursing* (7th ed.). Wolter Kluwer, Lippincott Wiliams & Wilkins

Friedman, L. M. (2015). *Buku ajar keperawatan keluarga: riset, teori, praktik* (5thed). Jakarta: EGC



BAB 8

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Apa tujuan utama dari pendekatan berbasis keluarga dalam manajemen TB pada anak?
 - A. Menghindari interaksi sosial
 - B. Menurunkan biaya rumah sakit
 - C. Meningkatkan kepatuhan pengobatan dan pencegahan penularan di lingkungan keluarga
 - D. Menyederhanakan diagnosis

Jawaban: C

2. Salah satu keuntungan dari pendekatan berbasis keluarga adalah:
 - A. Mengurangi kebutuhan nutrisi pasien
 - B. Mempercepat hasil pemeriksaan laboratorium
 - C. Meningkatkan dukungan emosional dan sosial pada anak
 - D. Menurunkan daya tahan tubuh anak

Jawaban: C

3. Siapa yang paling berperan dalam pendekatan berbasis keluarga dalam TB anak?
 - A. Petugas keamanan
 - B. Guru sekolah
 - C. Anggota keluarga, terutama orang tua
 - D. Teman bermain anak

Jawaban: C

4. Upaya pencegahan TB pada anak dalam keluarga yang terpapar TB aktif adalah:
- A. Isolasi anak secara total
 - B. Memberi antibiotik kuat tanpa resep
 - C. Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)
 - D. Membatasi makanan anak

Jawaban: C

5. Anak usia di bawah 5 tahun dengan kontak erat TB aktif harus mendapatkan:
- A. Vaksin influenza
 - B. Terapi Pencegahan TB meskipun tanpa gejala
 - C. Obat antibiotik umum
 - D. Vitamin C dosis tinggi

Jawaban: B

6. Faktor risiko utama anak terinfeksi TB di lingkungan rumah adalah:
- A. Konsumsi makanan pedas
 - B. Paparan asap kendaraan
 - C. Kontak erat dengan penderita TB aktif di rumah
 - D. Bermain di luar rumah

Jawaban: C

7. Strategi penting dalam pendekatan keluarga untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan adalah:
- A. Memberikan sanksi pada anak
 - B. Menyerahkan pengobatan pada tetangga
 - C. Pemantauan langsung oleh keluarga (DOTS berbasis keluarga)

D. Menghindari komunikasi dengan petugas kesehatan
Jawaban: C

8. Pendekatan berbasis keluarga menekankan pentingnya:
- A. Pemeriksaan anak-anak tetangga
 - B. Pendidikan dan pelibatan keluarga dalam seluruh proses pengobatan TB
 - C. Mengkarantina seluruh anggota keluarga
 - D. Memutus hubungan keluarga sementara

Jawaban: B

9. Peran petugas kesehatan dalam pendekatan ini adalah:
- A. Memberi obat dan meninggalkan rumah
 - B. Melatih keluarga sebagai pengawas minum obat (PMO)
 - C. Mengisolasi anak secara permanen
 - D. Memberikan sanksi sosial

Jawaban: B

10. Salah satu indikator keberhasilan pendekatan berbasis keluarga adalah:
- A. Meningkatnya jumlah kasus TB
 - B. Berkurangnya beban kerja rumah sakit
 - C. Menurunnya angka drop-out pengobatan TB pada anak
 - D. Bertambahnya waktu pengobatan

Jawaban: C

11. Vaksinasi yang diberikan untuk mencegah TB pada anak adalah:

- A. DPT
- B. BCG
- C. Polio
- D. MMR

Jawaban: B

12. Pengobatan TB pada anak harus dilakukan secara:

- A. Tidak teratur agar tidak kecanduan obat
- B. Hanya saat ada gejala
- C. Rutin, lengkap, dan diawasi
- D. Saat malam hari saja

Jawaban: C

13. Edukasi kepada keluarga tentang TB anak sebaiknya mencakup:

- A. Larangan bermain
- B. Pemberian antibiotik bebas
- C. Pengetahuan tentang penularan, gejala, dan pentingnya pengobatan
- D. Mitos seputar TB

Jawaban: C

14. TB pada anak seringkali sulit dikenali karena:

- A. Gejala tidak khas dan sulit diekspresikan
- B. Anak suka berbohong
- C. Anak terlalu aktif
- D. Pemeriksaan tidak bisa dilakukan

Jawaban: A

15. Kapan pendekatan berbasis keluarga paling efektif diterapkan dalam TB anak?

- A. Setelah anak sembuh
- B. Sejak awal diagnosis atau sejak ditemukan kontak erat
- C. Saat anak sudah parah
- D. Hanya jika anak demam tinggi

Jawaban: B

PROFIL PENULIS



Ns. Loriza Sativa Yan, M.N.S., Penulis menyelesaikan pendidikan S1 keperawatan-profesi Ners di Universitas Andalas, Padang, Indonesia. kemudian melanjutkan S2 Keperawatan di Kasetsart University, Bangkok, Thailand, dengan fokus Family and Community Health Nursing. Saat ini bekerja sebagai dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi.



Rian Yuliyana, S.Kep, Ners, M.N.S. Rian Yuliyana menyelesaikan pendidikan tinggi dimulai dari sarjana keperawatan dan profesi di Program Studi Ilmu Keperawatan yang saat ini merupakan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Riau. Beliau meraih Master of Nursing Science (Family and Community Health Nursing) with a major in Family and Community Health Nursing (International Program). Saat ini aktif mengajar di Prodi DIII Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.

PROFIL PENULIS



Ners. Syarbaini, S.Kep, M.KM. Lahir di Danau Emabat pada 14 Agustus 1971. Ia menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, Jakarta. Saat ini, ia aktif sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jambi dan memiliki pengalaman panjang dalam dunia pendidikan keperawatan serta pelayanan kesehatan masyarakat. Selain berkiprah sebagai tenaga pendidik, ia juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, di antaranya sebagai Ketua Pusbangdiklat DPW PPNI Provinsi Jambi dan Tim Coaching TBC Jambi. Kepedulianya terhadap pengembangan SDM kesehatan dan penanggulangan penyakit menular tercermin dari berbagai pelatihan dan kegiatan yang ia ikuti, seperti BTCL dan TOT ILT TBC. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang kuat, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan keperawatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.



Ns. Verra Widhi Astuti, M.Kep. Lahir di Purworejo tanggal 25 Februari 1991. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi D III Keperawatan Padang Poltekkes Kemenkes Padang. Menyelesaikan pendidikan S1 dan Ners di FIK UI dan melanjutkan S2 di FIK UI Peminatan Keperawatan Komunitas. Penulis saat ini mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Komunitas dan Gerontik.

SINOPSIS

Penguatan Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat pada Anak dengan Tuberkulosis Paru: Pendekatan Family Centered Empowerment Model Tuberkulosis (TBC) paru pada anak masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan di Indonesia. Proses pengobatan yang panjang dan ketat menuntut kepatuhan tinggi dari pasien, yang dalam kasus anak-anak sangat bergantung pada peran keluarga. Buku ini hadir untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan keluarga sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO) melalui pendekatan Family Centered Empowerment Model (FCEM). Pendekatan FCEM menempatkan keluarga sebagai pusat pemberdayaan dalam proses penyembuhan anak. Melalui empat tahap peningkatan persepsi ancaman, efikasi diri, partisipasi aktif, dan evaluasi keluarga diberi bekal untuk memahami penyakit TBC, meningkatkan kepercayaan diri dalam mendampingi anak, serta berpartisipasi aktif dalam pengobatan. Buku ini menekankan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga agar tercipta kemitraan yang saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan minum obat serta mempercepat kesembuhan anak. Isi buku mencakup penjelasan tentang konsep dasar TBC pada anak, pentingnya peran keluarga dalam keberhasilan terapi, dan strategi praktis menerapkan FCEM di rumah. Disertai contoh kasus, panduan komunikasi efektif, serta instrumen evaluasi sederhana, buku ini membantu keluarga mengenali hambatan seperti kurangnya pengetahuan, kelelahan emosional, dan stigma sosial, lalu menemukan solusi yang sesuai. Dengan pendekatan berbasis pemberdayaan, buku ini diharapkan

menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung penyembuhan TBC anak secara holistik dan berkelanjutan.

Penguatan Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat pada Anak dengan Tuberkulosis Paru: Pendekatan Family Centered Empowerment Model

Tuberkulosis (TBC) paru pada anak masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan di Indonesia. Proses pengobatan yang panjang dan ketat menuntut kepatuhan tinggi dari pasien, yang dalam kasus anak-anak sangat bergantung pada peran keluarga. Buku ini hadir untuk memperkuat pemahaman dan

kemampuan keluarga sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO) melalui pendekatan Family Centered Empowerment Model (FCEM). Pendekatan FCEM menempatkan keluarga sebagai pusat pemberdayaan dalam proses penyembuhan anak. Melalui empat tahap peningkatan persepsi ancaman, efikasi diri, partisipasi aktif, dan evaluasi keluarga diberi bekal untuk memahami penyakit TBC, meningkatkan kepercayaan diri dalam mendampingi anak, serta berpartisipasi aktif dalam pengobatan. Buku ini menekankan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga agar tercipta kemitraan yang saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan minum obat serta mempercepat kesembuhan anak.

Isi buku mencakup penjelasan tentang konsep dasar TBC pada anak, pentingnya peran keluarga dalam keberhasilan terapi, dan strategi praktis menerapkan FCEM di rumah. Disertai contoh kasus, panduan komunikasi efektif, serta

instrumen evaluasi sederhana, buku ini membantu keluarga mengenali hambatan seperti kurangnya pengetahuan, kelelahan emosional, dan stigma sosial, lalu menemukan solusi yang sesuai. Dengan pendekatan berbasis

pemberdayaan, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan rumah yang mendukung penyembuhan TBC anak secara holistik dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-27-7



9

786347

426277

